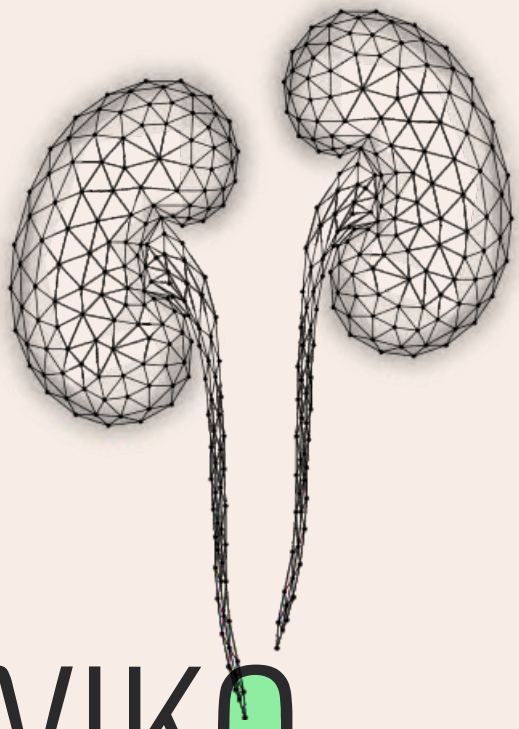


Ετήσιο Ουρολογικό Συνέδριο

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ

www.ur-congress.gr

ΙΕΕΟΥ
ινστιτούτο έρευνας & εφαρμογών ουροποιογεννητικού συστήματος

16-18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
MAKEDONIA PALACE

VOYAGER TRAVEL & CONGRESS

Γραφείο Οργάνωσης: **VOYAGER TRAVEL AND CONGRESS**, Βασ. Ηρακλείου 26, 54624 Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2310.250401, 2310.250403, Fax: 2310.250418, e-mail: info@voyagertravel.gr, **www.voyagertravel.gr**

ERLEADA® Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος

Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες. Βλ. παράγραφο Ανεπιθύμητες ενέργειες για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών.

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: Erleada 60 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία **ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:** Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 60 mg apalutamide. **ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ:** Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο (δισκίο). Ελαφρώς κιτρινωπά προς γκριζοπράσινα, επιμήκη, επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία (16,7 mm μήκος x 8,7 mm πλάτος), με χαραγμένη την ένδειξη «AR 60» στη μία πλευρά. **ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Θεραπευτικές ενδείξεις:** Το Erleada ενδείκνυται: • για τη θεραπεία του μη μεταστατικού, ανθεκτικού στον ευνουχισμό καρκίνου του προστάτη (nm-CRPC) σε ενήλικους άνδρες, οι οποίοι διατρέχουν υψηλό κίνδυνο να αναπτύξουν μεταστατική νόσο. • σε ενήλικους άνδρες για τη θεραπεία του μεταστατικού, ορμονοευαίσθητου καρκίνου του προστάτη (mHSPC) σε συνδυασμό με θεραπεία στέρησης ανδρογόνων (ADT). **Αντενδείξεις:** Υπερευαισθησία στη δραστική ουσία ή σε κάποιο από τα έκδοχα. Γυναίκες που είναι ή ενδέχεται να μείνουν έγκυες. **Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση:** Επιληπτικές κρίσεις: Το Erleada δεν ενδείκνυται σε ασθενείς με ιστορικό επιληπτικών κρίσεων ή άλλων προδιαθεσικών παραγόντων, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων υποκείμενου εγκεφαλικού τραύματος, πρόσφατου αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου (εντός ενός έτους), πρωτοπαθών όγκων εγκεφάλου ή εγκεφαλικών μεταστάσεων. Εάν παρουσιαστεί επιληπτική κρίση κατά τη διάρκεια της θεραπείας με Erleada, η θεραπεία θα πρέπει να διακοπεί οριστικά. Ο κίνδυνος για επιληπτικές κρίσεις ενδέχεται να είναι αυξημένος σε ασθενείς που λαμβάνουν ταυτόχρονα φαρμακευτικά προϊόντα τα οποία μειώνουν τον ουδό των επιληπτικών κρίσεων. Σε δύο τυχαιοποιημένες μελέτες (SPARTAN και TITAN), επιληπτικές κρίσεις εμφανίστηκαν στο 0,6% των ασθενών που έλαβαν apalutamide και στο 0,2% των ασθενών που έλαβαν θεραπεία με εικονικό φάρμακο. Σε αυτές τις κλινικές μελέτες αποκλείστηκε η συμμετοχή ασθενών με ιστορικό επιληπτικών κρίσεων ή προδιαθεσικούς παράγοντες για επιληπτικές κρίσεις. Δεν υπάρχει κλινική εμπειρία στην εκ νέου χορήγηση Erleada σε ασθενείς που εμφάνισαν επιληπτική κρίση. Πτώσεις και κατάγματα: Πτώσεις και κατάγματα σημειώθηκαν σε ασθενείς που έλαβαν apalutamide (βλέπε παράγραφο Ανεπιθύμητες ενέργειες). Οι ασθενείς θα πρέπει να αξιολογούνται σχετικά με τον κίνδυνο για πτώσεις και κατάγματα πριν την έναρξη του Erleada και η παρακολούθηση και η διαχείρισή τους θα πρέπει να συνεχίζεται σύμφωνα με τις καθιερωμένες συστάσεις θεραπείας και θα πρέπει να εξετάζεται το ενδεχόμενο χρήσης παραγόντων στόχευσης των οστών. Ισχαιμική καρδιοπάθεια και ισχαιμικές διαταραχές των αγγείων του εγκεφάλου: Ισχαιμική καρδιοπάθεια και ισχαιμικές διαταραχές των αγγείων του εγκεφάλου, συμπεριλαμβανομένων συμβάντων που οδήγησαν σε θάνατο, εμφανίστηκαν σε ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με apalutamide (βλ. παράγραφο Ανεπιθύμητες ενέργειες). Η πλειοψηφία των ασθενών είχαν παράγοντες κινδύνου καρδιακής / ισχαιμικής αγγειακής εγκεφαλικής νόσου. Οι ασθενείς θα πρέπει να παρακολουθούνται για σημεία και συμπτώματα ισχαιμικής καρδιοπάθειας και ισχαιμικών διαταραχών των αγγείων του εγκεφάλου. Η διαχείριση παραγόντων κινδύνου, όπως η υπέρταση, ο διαβήτης ή η δυαλιπιδαιμία θα πρέπει να βελτιστοποιείται, σύμφωνα με την καθιερωμένη φροντίδα. Ταυτόχρονη χρήση με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα: Το apalutamide είναι ένας ισχυρός επαγωγέας ενζύμων και μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια της αποτελεσματικότητας πολλών φαρμακευτικών προϊόντων ευρείας χρήσεως. Συνεπώς, θα πρέπει να γίνεται επανεξέταση των συγχορηγούμενων φαρμακευτικών προϊόντων κατά την έναρξη της θεραπείας με apalutamide. Η ταυτόχρονη χρήση του apalutamide με φαρμακευτικά προϊόντα που είναι ευαίσθητα υποστρώματα πολλών μεταβολικών ενζύμων ή μεταφορέων θα πρέπει γενικά να αποφεύγεται εάν η θεραπευτική τους δράση είναι μεγάλης σημασίας για τον ασθενή και δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν εύκολα προσαρμογές της δόσης, βάσει της παρακολούθησης της αποτελεσματικότητας ή των συγκεντρώσεων στο πλάσμα. Η συγχορήγηση του apalutamide με βαρφαρίνη και κουμαρινικά αντιπηκτικά θα πρέπει να αποφεύγεται. Εάν το Erleada συγχορηγείται με ένα αντιπηκτικό που μεταβολίζεται από το CYP2C9 (όπως η βαρφαρίνη ή η ασενοκουμαρόλη), θα πρέπει επιπροσθέτως να παρακολουθείται ο Διεθνής Κανονικοποιημένος Λόγος (INR). Πρόσφατη καρδιαγγειακή νόσος: Ασθενείς με κλινικά σημαντική καρδιαγγειακή νόσο κατά τους τελευταίους 6 μήνες, συμπεριλαμβανομένης της συοβαρής/ασταθούς στηθάγχης, του εμφράγματος του μυοκαρδίου, της συμπτωματικής συμφορητικής καρδιακής ανεπάρκειας, των αρτηριακών ή φλεβικών θρομβοεμβολικών επεισοδίων (π.χ., πνευμονική εμβολή, αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, συμπεριλαμβανομένων των παροδικών ισχαιμικών επεισοδίων) ή των κλινικά σημαντικών κοιλιακών αρρυθμιών αποκλείστηκαν από τις κλινικές μελέτες. Ως εκ τούτου, δεν έχει τεκμηριωθεί η ασφάλεια του apalutamide σε αυτούς τους ασθενείς. Εάν το Erleada συνταγογραφηθεί, οι ασθενείς με κλινικά σημαντική καρδιαγγειακή νόσο θα πρέπει να παρακολουθούνται για παράγοντες κινδύνου όπως υπερχοληστερολαιμία, υπερτριγλυκεριδαιμία ή άλλες καρδιομεταβολικές διαταραχές (βλ. παράγραφο Ανεπιθύμητες ενέργειες). Οι ασθενείς θα πρέπει να λαμβάνουν θεραπεία για αυτές τις καταστάσεις, εφόσον απαιτείται, μετά την έναρξη του Erleada, σύμφωνα με τις καθιερωμένες συστάσεις θεραπείας. Η θεραπεία στέρησης ανδρογόνων μπορεί να παρατείνει το διάστημα QT: Σε ασθενείς με ιστορικό ή παράγοντες κινδύνου για παράταση του διαστήματος QT, καθώς και σε ασθενείς που λαμβάνουν ταυτόχρονα φαρμακευτικά προϊόντα τα οποία ενδέχεται να παρατείνουν το διάστημα QT, οι ιατροί θα πρέπει να αξιολογούν την αναλογία οφέλους-κινδύνου, συμπεριλαμβανομένης της πιθανότητας εμφάνισης κοιλιακής ταχυκαρδίας δίκην ριπιδίου (Torsade de pointes) πριν την έναρξη του Erleada. Σύνδρομο Stevens-Johnson (SJS)/τοξική επιδερμική νεκρόλυση (TEN): Αναφορές SJS/TEN μετά την κυκλοφορία, τα οποία μπορεί να είναι απειλητικά για τη ζωή ή θανατηφόρα, έχουν παρατηρηθεί σε συσχέτιση με τη θεραπεία με Erleada και η συχνότητα εμφάνισης είναι «μη γνωστές» (βλέπε παράγραφο Ανεπιθύμητες ενέργειες). Οι ασθενείς πρέπει να ενημερώνονται σχετικά με σημεία και συμπτώματα που υποδηλώνουν SJS/TEN. Εάν παρατηρηθούν αυτά τα συμπτώματα, το Erleada θα πρέπει να διακοπεί αμέσως και οι ασθενείς θα πρέπει να αναζητήσουν άμεση ιατρική συμβουλή. Το Erleada δεν πρέπει να ξεκινά εκ νέου σε ασθενείς που παρουσίασαν SJS/TEN οποιαδήποτε στιγμή ενόσω λάμβαναν Erleada και θα πρέπει να εξετάζεται το ενδεχόμενο εναλλακτικής θεραπείας. **Ανεπιθύμητες ενέργειες:** Περίληψη του προφίλ ασφάλειας: Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες είναι κόπωση (26%), δερματικό εξάνθημα (26% οποιουδήποτε βαθμού και 6% βαθμού 3 ή 4), υπέρταση (22%), έξαψη (18%), αρθραλγία (17%), διάρροια (16%), πτώση (13%) και μείωση σωματικού βάρους (13%). Άλλες σημαντικές ανεπιθύμητες ενέργειες περιλαμβάνουν κατάγματα (11%) και υποθυρεοειδισμό (8%). Κατάλογος ανεπιθύμητων ενεργειών σε μορφή πίνακα: Οι ανεπιθύμητες ενέργειες που παρατηρήθηκαν κατά τη διάρκεια κλινικών μελετών παρατίθενται παρακάτω ανά κατηγορία συχνότητας εμφάνισης. Οι κατηγορίες συχνότητας εμφάνισης ορίζονται ως ακολούθως: πολύ συχνές (≥ 1/10), συχνές (≥ 1/100 έως < 1/10), όχι συχνές (≥ 1/1 000 έως < 1/100), σπάνιες (≥ 1/10 000 έως < 1/1 000), πολύ σπάνιες (< 1/10 000) και μη γνωστές (η συχνότητα εμφάνισης δεν μπορεί να εκτιμηθεί με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα). Εντός κάθε κατηγορίας συχνότητας εμφάνισης, οι ανεπιθύμητες ενέργειες παρατίθενται κατά φθίνουσα σειρά σοβαρότητας.

Πίνακας 1: Ανεπιθύμητες ενέργειες που διαπιστώθηκαν σε κλινικές μελέτες

Κατηγορία/Οργανικό Σύστημα	Ανεπιθύμητη ενέργεια και συχνότητα εμφάνισης[a]
Διαταραχές του ενδοκρινικού συστήματος	συχνές: υποθυρεοειδισμός[β]
Διαταραχές του μεταβολισμού και της θρέψης	πολύ συχνές: μειωμένη όρεξη
	συχνές: υπερχοληστερολαιμία, υπερτριγλυκεριδαιμία
Διαταραχές του νευρικού συστήματος	συχνές: δυσγευσία, ισχαιμικές διαταραχές των αγγείων του εγκεφάλου[γ]
	όχι συχνές: επιληπτική κρίση[δ] (βλ. παράγραφο Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση)
Καρδιακές διαταραχές	συχνές: ισχαιμική καρδιοπάθεια[ε]
	μη γνωστές: παράταση του διαστήματος QT (βλ. παράγραφο Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση)
Αγγειακές διαταραχές	πολύ συχνές: έξαψη, υπέρταση
Διαταραχές του γαστρεντερικού	πολύ συχνές: διάρροια
Διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού	πολύ συχνές: δερματικό εξάνθημα[ζ]
	συχνές: κνησμός, άλωπεκία
	μη γνωστές: σύνδρομο Stevens-Johnson/τοξική επιδερμική νεκρόλυση[η,θ]
Διαταραχές του μυοσκελετικού συστήματος και του συνδετικού ιστού	πολύ συχνές: κάταγμα[ι], αρθραλγία
	συχνές: μυϊκός σπασμός
Γενικές διαταραχές και καταστάσεις της οδού χορήγησης	πολύ συχνές: κόπωση
Παρακλινικές εξετάσεις	πολύ συχνές: μειωμένο σωματικό βάρος
Κακώσεις, δηλητηριάσεις και επιπλοκές θεραπευτικών χειρισμών	πολύ συχνές: πτώση

[a] Οι συχνότητες των ανεπιθύμητων ενεργειών που παρουσιάζονται βασίζονται στην ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο περίοδο των κλινικών μελετών

[β] Περιλαμβάνεται υποθυρεοειδισμός, αυξημένα επίπεδα θυρεοειδοτρόπου ορμόνης στο αίμα, μειωμένη θυροξίνη, αυτοάνοση θυρεοειδίτιδα, μειωμένη ελεύθερη θυροξίνη, μειωμένη τριιωδοθυρονίνη

[γ] Περιλαμβάνεται παροδικό ισχαιμικό επεισόδιο, αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, διαταραχή των αγγείων του εγκεφάλου, ισχαιμικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, αρτηριοσκλήρυνση καρωτίδας, στένωση καρωτίδας, ημιπάρεση, βοθριωτό έμφρακτο, βοθριωτό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, θρομβωτικό εγκεφαλικό έμφρακτο, αγγειακή εγκεφαλοπάθεια, έμφρακτο παρεγκεφαλίδας, εγκεφαλικό έμφρακτο και εγκεφαλική ισχαιμία

[δ] Περιλαμβάνει δάγκωμα της γλώσσας

[ε] Περιλαμβάνει στηθάγχη, ασταθή στηθάγχη, έμφραγμα του μυοκαρδίου, οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου, απόφραξη στεφαναιάς αρτηρίας, στένωση στεφαναιάς αρτηρίας, οξύ στεφαναιάο σύνδρομο, αρτηριοσκλήρυνση στεφαναιάς αρτηρίας, δοκιμασία κοπώσεως μη φυσιολογική, αυξημένη τροπονίνη, ισχαιμία του μυοκαρδίου

[ζ] Βλέπε «Δερματικό εξάνθημα» στην ενότητα «Περιγραφή επιλεγμένων ανεπιθύμητων ενεργειών»

[η] Ανεπιθύμητη ενέργεια μετά την κυκλοφορία

[θ] Βλέπε παράγραφο 4.4

[ι] Περιλαμβάνεται κάταγμα πλευρών, κάταγμα οσφυϊκού σπονδύλου, συμπιεστικό κάταγμα σπονδυλικής στήλης, κάταγμα σπονδυλικής στήλης, κάταγμα άκρου ποδός, κάταγμα ισχίου, κάταγμα βραχιόνιου οστού, κάταγμα θωρακικού σπονδύλου, κάταγμα άνω άκρου, κάταγμα ιερού οστού, κάταγμα άκρας χείρας, κάταγμα ηβικού οστού, κάταγμα κοτύλης, κάταγμα αστραγάλου, συμπιεστικό κάταγμα, κάταγμα πλευρικού χόνδρου, κάταγμα οστών του προσώπου, κάταγμα κάτω άκρου, οστεοπορωτικό κάταγμα, κάταγμα καρπού, αποσπαστικό κάταγμα, κάταγμα περόνης, κάταγμα κόκκυγα, κάταγμα πυελου, κάταγμα κερκίδας, κάταγμα στέρνου, κάταγμα από υπερβολική επίβαρυνση, μετατραυματικό κάταγμα, κάταγμα αυχενικού σπονδύλου, κάταγμα του αυχένα του μηριαίου οστού, κάταγμα κνήμης. Βλέπε παρακάτω.

Περιγραφή επιλεγμένων ανεπιθύμητων ενεργειών: *Δερματικό εξάνθημα:* Το δερματικό εξάνθημα που σχετίζεται με το apalutamide περιγράφηκε συνήθως ως κηλιδώδες ή κηλιδοβλατιδώδες. Στο δερματικό εξάνθημα περιλαμβάνεται εξάνθημα, κηλιδοβλατιδώδες εξάνθημα, γενικευμένο εξάνθημα, κνίδωση, κνησμώδες εξάνθημα, κηλιδώδες εξάνθημα, επιπεφυκίτιδα, πολύμορφο ερύθημα, βλατιδώδες εξάνθημα, αποφολίδωση δέρματος, εξάνθημα γενννητικών οργάνων, ερυθηματώδες εξάνθημα, στοματίτιδα, φαρμακευτικό εξάνθημα, στοματικά έλκη, φλυκταινώδες εξάνθημα, φλύκταινες, βλατίδες, πεμφιγοειδές, διάβρωση του δέρματος, δερματίτιδα και κυστικό εξάνθημα Ανεπιθύμητες ενέργειες δερματικού εξανθήματος αναφέρθηκαν στο 26% των ασθενών που έλαβαν apalutamide. Βαθμού 3 δερματικά εξανθήματα (ορίστηκαν ως εκείνα που καλύπτουν > 30% της επιφάνειας σώματος [BSA]) αναφέρθηκαν με τη θεραπεία με apalutamide στο 6% των ασθενών. Ο διάμεσος χρόνος έως την εμφάνιση δερματικού εξανθήματος ήταν 83 ημέρες. Στο 78% των ασθενών το εξάνθημα απέδραμε, με διάμεσο χρόνο έως την αποδρομή 78 ημέρες. Στα φαρμακευτικά προϊόντα που χρησιμοποιήθηκαν περιλαμβάνονταν τοπικά κορτικοστεροειδή, από στόματος αντιισταμινικά και το 19% των ασθενών έλαβαν συστηματικά κορτικοστεροειδή. Στους ασθενείς με δερματικό εξάνθημα, η δόση διεκόπη στο 28% των ασθενών και ελαττώθηκε στο 14% των ασθενών. Το δερματικό εξάνθημα επανεμφανίστηκε στο 59% των ασθενών στους οποίους πραγματοποιήθηκε προσωρινή διακοπή της δόσης. Το δερματικό εξάνθημα οδήγησε σε διακοπή της θεραπείας με apalutamide στο 7% των ασθενών που εμφάνισαν δερματικό εξάνθημα. *Πτώσεις και κατάγματα:* Στη μελέτη ARN-509-003, κάταγμα αναφέρθηκε στο 11,7% των ασθενών που έλαβαν apalutamide και στο 6,5% των ασθενών που έλαβαν εικονικό φάρμακο. Οι μισοί ασθενείς είχαν πτώση μέσα σε διάστημα 7 ημερών πριν από το κάταγμα και στις δύο ομάδες θεραπείας. Πτώσεις αναφέρθηκαν στο 15,6% των ασθενών που έλαβαν apalutamide, έναντι 9,0% των ασθενών που έλαβαν εικονικό φάρμακο (βλ. παράγραφο Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση). *Ισχαιμική καρδιοπάθεια και ισχαιμικές διαταραχές των αγγείων του εγκεφάλου:* Σε μία τυχαιοποιημένη μελέτη (SPARTAN) σε ασθενείς με nmCRPC, ισχαιμική καρδιοπάθεια εμφανίστηκε στο 4% των ασθενών που έλαβαν θεραπεία με apalutamide και στο 3% των ασθενών που έλαβαν εικονικό φάρμακο. Σε μία τυχαιοποιημένη μελέτη (TITAN) σε ασθενείς με mHSPC, ισχαιμική καρδιοπάθεια εμφανίστηκε στο 4% των ασθενών που έλαβαν θεραπεία με apalutamide και στο 2% των ασθενών που έλαβαν εικονικό φάρμακο. Συνολικά, στις μελέτες SPARTAN και TITAN, 6 ασθενείς (0,5%) που έλαβαν apalutamide και 2 ασθενείς (0,2%) που έλαβαν εικονικό φάρμακο απεβίωσαν λόγω ισχαιμικής καρδιοπάθειας (βλ. παράγραφο Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση). Στη μελέτη SPARTAN, με μία διάμεση έκθεση 32,9 μηνών για το apalutamide και 11,5 μηνών για το εικονικό φάρμακο, ισχαιμικές διαταραχές των αγγείων του εγκεφάλου εμφανίστηκαν στο 4% των ασθενών που έλαβαν θεραπεία με apalutamide και στο 1% των ασθενών που έλαβαν εικονικό φάρμακο (βλ. παραπάνω). Στη μελέτη TITAN, ισχαιμικές διαταραχές των αγγείων του εγκεφάλου εμφανίστηκαν σε παρόμοια αναλογία στους ασθενείς στις ομάδες του apalutamide (1,5%) και του εικονικού φαρμάκου (1,5%). Συνολικά, στις μελέτες SPARTAN και TITAN, 2 ασθενείς (0,2%) που έλαβαν apalutamide και κανένας από τους ασθενείς που έλαβαν εικονικό φάρμακο απεβίωσαν λόγω ισχαιμικής διαταραχής των αγγείων του εγκεφάλου (βλ. παράγραφο Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση). *Υποθυρεοειδισμός:* Υποθυρεοειδισμός αναφέρθηκε στο 8% των ασθενών που έλαβαν apalutamide και στο 2% των ασθενών που έλαβαν εικονικό φάρμακο, με βάση τις αξιολογήσεις της θυρεοειδοτρόπου ορμόνης (TSH) ανά 4 μήνες. Δεν παρατηρήθηκαν ανεπιθύμητες ενέργειες Βαθμού 3 ή 4. Υποθυρεοειδισμός εμφανίστηκε στο 30% των ασθενών που λάμβαναν ήδη θεραπεία υποκατάστασης του θυρεοειδούς στο σκέλος του apalutamide και στο 3% των ασθενών στο σκέλος του εικονικού φαρμάκου. Στους ασθενείς που δεν λάμβαναν θεραπεία υποκατάστασης του θυρεοειδούς, υποθυρεοειδισμός εμφανίστηκε στο 7% των ασθενών που έλαβαν apalutamide και στο 2% των ασθενών που έλαβαν εικονικό φάρμακο. Όταν ενδείκνυται κλινικά, πρέπει να ξεκινά θεραπεία υποκατάστασης του θυρεοειδούς ή να προσαρμόζεται η δόση της. Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών: Η αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας του φαρμακευτικού προϊόντος είναι σημαντική. Επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση της σχέσης οφέλους-κινδύνου του φαρμακευτικού προϊόντος. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες μέσω του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, Μεσογείων 284, GR-15562 Χολαργός, Αθήνα. Τηλ: + 30 21 32040380/337, Φαξ: + 30 21 06549585, Ιστότοπος: http://www.eof.gr. **ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:** Janssen-Cilag International NV, Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse, Βέλγιο. **ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:** EU/1/18/1342/001. **ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:** 10 Φεβρουαρίου 2022. Λεπτομερείς πληροφορίες για το παρόν φαρμακευτικό προϊόν είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων http://www.ema.europa.eu. **ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ:** Περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό και παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της αγωγής.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ / ΤΙΜΕΣ

Περιεκτικότητα	Συσκευασία	Νοσοκομειακή Τιμή	Λιανική Τιμή
F.C.TAB 60MG/TAB	BTx112 δισκία σε blisters PVC/PCTFE/alu	2.415,28 €	2.918,66 €

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εταιρεία Janssen-Cilag Φαρμακευτική Α.Ε.Β.Ε., Λ. Ειρήνης 56, 151 21 Πεύκη, τηλ. 210 8090000.

PSA

Erleada® (apalutamide) tablets

ΠΟΣΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΟΔΟΥ ΤΟΥ PSA ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ mHSPC;

Η μείωση του PSA συνδέεται με παράταση της επιβίωσης[2,5]

Η μείωση του PSA συνδέεται με διατήρηση της σχετιζόμενης με την υγεία ποιότητας ζωής (HRQoL)[5,6]

Η μείωση του PSA σε μη ανιχνεύσιμα επίπεδα (≤0,2 ng/mL) ή ≥90% από την αρχική τιμή ορίζεται ως «βαθιά μείωση»[5,6]

Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες.

ADT: θεραπεία στέρησης ανδρογόνων, OS: συνολική επιβίωση, PSA: ειδικό προστατικό αντιγόνο, QOL: ποιότητα ζωής, mHSPC: μεταστατικός ορμονοευαίσθητος καρκίνος του προστάτη.

Βιβλιογραφία:
1. ERLEADA® Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος. **2.** K. N. Chi, et al. Prostate-specific antigen kinetics in patients with advanced prostate cancer treated with apalutamide: results from the TITAN and SPARTAN studies. Poster presented at the APSHO JADPRO congress, 7-17 October 2021. **3.** Thiery-Vuillemin A, et al. Oncologist 2021;26:e1179-e1188. **4.** Lim DM, et al. Prostate 2018;10.1002/pros.23666. **5.** Chi KN, et al. J Clin Oncol 2021;39:2294–2303. **6.** Small EJ, et al. ASCO Genitourinary Cancers Symposium, 17–19 February 2022. Poster D1.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Περιεκτικότητα F.C.TAB 60MG/TAB,
Συσκευασία BTx112 δισκία σε blisters PVC/PCTFE/alu,
Νοσοκομειακή Τιμή-2.415,28 €, Λιανική Τιμή-2.918,66 €

Η Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος βρίσκεται σε επόμενη σελίδα.

JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.
Λεωφόρος Ειρήνης 56, 151 21, Πεύκη, Αθήνα, Τηλ.: 210 8090000
www.janssen.com.gr

Μάθετε περισσότερα στο Janssen Medical Cloud

Janssen Oncology
PHARMACEUTICAL COMPANIES OF Johnson&Johnson

CP-343370/ERL/0922/004

Mefoxil®

cefoxitin sodium 1g/vial
2g/vial

Διαχρονική αξία στις λοιμώξεις

1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: MEFOXIL **2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ** Κάθε φιαλίδιο περιέχει cefoxitin sodium 1,051g που ισοδυναμεί με cefoxitin 1g. Κάθε φιαλίδιο περιέχει cefoxitin sodium 2,104g που ισοδυναμεί με cefoxitin 2g. **3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ:** Κόνις για ενέσιμο διάλυμα. **7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:** ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε - Οδός Τατοΐου, 146 71 Νέα Ερυθραία - Τηλ. 210 8009111-120 10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ (ΜΕΡΙΚΗΣ) ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: 08-11-2018

MEFOXIL 1g/vial Ν.Τ 3,77€, Λ.Τ 5,97€. 2g/vial Ν.Τ 5,51€, Λ.Τ 8,73€

Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται από τον ΚΑΚ κατόπιν αιτήσεως

Τρόπος Διάθεσης: Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή

BIANEΞ A.E.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

BIANEΞ Α.Ε. - Έδρα : οδός Τατοΐου, 18ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας
146 71 Ν. Ερυθραία Αττικής, Ταχ. Θυρίδα 52894, 146 10 Ν. Ερυθραία
Τηλ. : 210 8009111• Fax: 210 8071573 • E-mail: mailbox@vianex.gr • WEBSITE: www.vianex.gr
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Ακαδήμου 113, 562 24 Εύοσμος Θεσσαλονίκης , Τηλ.: 2310 861683

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000274201000

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

VE 22248 MEF 9/2022

Ετήσιο Ουρολογικό Συνέδριο
ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ

περιεχόμενα

07
Χαιρετισμός

08-09
Προεδρείο – Επιτροπές

10
Γενικές Πληροφορίες

13-17
Πρόγραμμα

18
Ευρετήριο

22
Χορηγοί

24
Σημειώσεις

Ivor®
Bemiparin sodium

IvorMAX®
Bemiparin sodium

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: Ivor 2.500 IU antiXa/0,2 ml ενέσιμου διαλύματος σε προγεμισμένες σύριγγες **ΠΟΙΟΤΙΚΗ & ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:** Bemiparin sodium: 2.500 IU (anti Factor Xa*) ανά 0,2 ml προγεμισμένη σύριγγα (ισοδύναμη με 12.500 IU (anti Factor Xa*) ανά ml ενέσιμου διαλύματος). Η δραστικότητα περιγράφεται σε Διεθνείς μονάδες anti-Factor Xa δραστικότητας (IU) με βάση το Πρώτο Διεθνές Πρότυπο Αναφοράς Ηπαρίνης Χαμηλού Μοριακού Βάρους. Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ. παράγραφο 6.1. **ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ/ΤΙΜΕΣ:** IVOR 2.500 IU anti-Xa/0,2 ml BT x 2 PF.SYR Λ.Τ.: 5,83 €

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: Ivor 3.500 IU antiXa/0,2 ml ενέσιμου διαλύματος σε προγεμισμένες σύριγγες. **ΠΟΙΟΤΙΚΗ & ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:** Bemiparin sodium: 3.500 IU (anti Factor Xa*) ανά 0,2 ml προγεμισμένη σύριγγα (ισοδύναμη με 17.500 IU (anti Factor Xa*) ανά ml ενέσιμου διαλύματος). Η δραστικότητα περιγράφεται σε Διεθνείς μονάδες anti-Factor Xa δραστικότητας (IU) με βάση το Πρώτο Διεθνές Πρότυπο Αναφοράς Ηπαρίνης Χαμηλού Μοριακού Βάρους. Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ. παράγραφο 6.1. **ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ/ΤΙΜΕΣ:** IVOR 3.500 IU anti-Xa/0,2 ml BT x 2 PF.SYR Λ.Τ.: 10,74 BT x 30 PF.SYR Λ.Τ.: 120,83 €

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: Ivormax 25.000 IU anti-Xa/ml ενέσιμου διαλύματος σε προγεμισμένες σύριγγες **ΠΟΙΟΤΙΚΗ & ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:** Bemiparin sodium: 25.000 IU (anti-Factor Xa*) ανά ml ενέσιμου διαλύματος. Ισοδύναμη με: 5.000 IU (anti-Factor Xa) ανά 0,2 ml προγεμισμένη σύριγγα, 7.500 IU (anti-Factor Xa) ανά 0,3 ml προγεμισμένη σύριγγα, 10.000 IU (anti-Factor Xa) ανά 0,4 ml προγεμισμένη σύριγγα. * Η δραστικότητα περιγράφεται σε Διεθνείς μονάδες anti-Factor Xa δραστικότητας (IU) με βάση το Πρώτο Διεθνές Πρότυπο Αναφοράς Ηπαρίνης Χαμηλού Μοριακού Βάρους. Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ. παράγραφο 6.1. **ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ/ΤΙΜΕΣ:** IVORMAX 25.000 IU anti-Xa/ml, BTx2PF.SYRx0,2ML Λ.Τ.: 21,86€, IVORMAX 25.000 IU anti-Xa/ml, BTx2PF.SYRx0,3ML Λ.Τ.: 19,09€, IVORMAX 25.000 IU anti-Xa/ml BTx2PF.SYRx0,4ML Λ.Τ.: 23,33€

ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: Ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένες σύριγγες. (Άχρωμο ή ελαφρώς κιτρινωπό, διαυγές διάλυμα, ελεύθερο ορατών σωματιδίων). ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: BIANEΞ Α.Ε. – Οδός Τατοΐου, 146 71 Νέα Ερυθραία, **Τηλ**. 210 8009111.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: 12-10-2021

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ: Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή

Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται από τον ΚΑΚ κατόπιν αιτήσεως.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

BIANEΞ Α.Ε.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

BIANEΞ Α.Ε. - Έδρα : οδός Τατοΐου, 18ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας 146 71 Ν. Ερυθραία Αττικής, Ταχ. Θυρίδα 52894, 146 10 Ν. Ερυθραία
Τηλ. : 210 8009111• Fax: 210 8071573 • E-mail: mailbox@vianex.gr • WEBSITE: www.vianex.gr
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Ακαδήμου 113, 562 24 Εύοσμος Θεσσαλονίκης Τηλ.: 2310 861683

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000274201000

VE-22096-IVO-4/2022

χαιρετισμός

Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι,

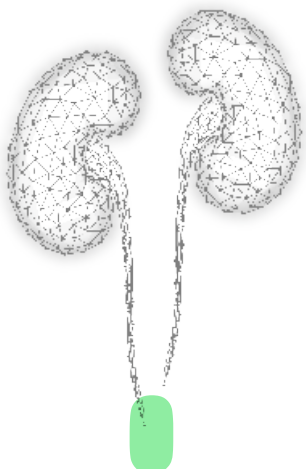
Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω στην 11η ετήσια επιστημονική συνάντηση που διοργανώνει το Ινστιτούτο Έρευνας και Εφαρμογών του Ουροποιογεννητικού Συστήματος (ΙΕΕΟΥ), σε συνεργασία με τη Β΄ Ουρολογική Κλινική του Α.Π.Θ. που θα διεξαχθεί από τις 16 έως τις 18 Δεκεμβρίου 2022 στη Θεσσαλονίκη. Το φετινό συνέδριο θα πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία αποκλειστικά μετά από 3 χρόνια.

Η θεματολογία του συνεδρίου περιλαμβάνει δύο διαδραστικά φροντιστήρια στις λειτουργικές παθήσεις του κατώτερου ουροποιητικού και πλαισιώνεται από διαλέξεις και δορυφορικά συμπόσια σε ενδιαφέροντα θέματα που αφορούν τον καρκίνο του προστάτη και τη χρήση φαρμάκων φυτικής προέλευσης στην αντιμετώπιση των ουρολοιμώξεων. Επιπλέον, εγκαινιάζονται τρία νέα θεματικά πεδία (μύθοι και πραγματικότητα, εφιάλτες στην Ουρολογία και Tips & Tricks) που θα δώσουν απαντήσεις σε καθημερινά ερωτήματα.

Είμαι βέβαιος ότι και το φετινό συνέδριο θα είναι υψηλού επιπέδου και θα αποτελέσει ευκαιρία για ανταλλαγή επιστημονικών απόψεων και σας εύχομαι να απολαύσετε τις εργασίες του καθώς και την παραμονή σας στην πόλη.

Με εκτίμηση,

Κωνσταντίνος Χατζημουρατίδης
Καθηγητής Ουρολογίας Α.Π.Θ.
Πρόεδρος ΙΕΕΟΥ



Ετήσιο Ουρολογικό Συνέδριο
ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ

Πρόεδρος Συνεδρίου

Χατζημουρατίδης Κωνσταντίνος
Πρόεδρος ΙΕΕΟΥ
Καθηγητής Ουρολογίας Α.Π.Θ., Διευθυντής Β΄ Ουρολογικής Κλινικής Α.Π.Θ., Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου»

Αντιπρόεδροι

Αποστολίδης Απόστολος
Καθηγητής Ουρολογίας – Νευροουρολογίας Α.Π.Θ., Β΄ Ουρολογική Κλινική Α.Π.Θ., Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου»

Γιακουμέλος Αλέξανδρος
Διευθυντής Ουρολογίας, Β΄ Ουρολογική Κλινική Α.Π.Θ., Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου»

Μωυσίδης Κυριάκος
Επίκουρος Καθηγητής Ουρολογίας Β΄ Ουρολογική Κλινική Α.Π.Θ., Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου»

Οργανωτική Επιτροπή

Χατζημουρατίδης Κωνσταντίνος

Αποστολίδης Απόστολος

Γιακουμέλος Αλέξανδρος

Μωυσίδης Κυριάκος

Σοκολάκης Ιωάννης

Καλινδέρης Νικόλαος

Μυκωνίου Αντώνιος

Επιστημονική επιτροπή

Πρόεδρος

Αποστολίδης Απόστολος
Καθηγητής Ουρολογίας - Νευροουρολογίας Α.Π.Θ., Β΄ Ουρολογική Κλινική Α.Π.Θ., Γ.Ν.Θ. «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ»

Μέλη

Αποστολίδης Απόστολος
Καθηγητής Ουρολογίας - Νευροουρολογίας Α.Π.Θ., Β΄ Ουρολογική Κλινική Α.Π.Θ., Γ.Ν.Θ. «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ»

Άρσος Γεώργιος
Καθηγητής Πυρηνικής Ιατρικής Α.Π.Θ., Διευθυντής Γ΄Εργαστηρίου Πυρηνικής Ιατρικής Ιατρικού Τμήματος Α.Π.Θ., Π.Γ.Ν.Θ.«ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ»

Βακαλόπουλος Ιωάννης
Χειρουργός - Ουρολόγος, Καθηγητής Ουρολογίας - Ανδρολογίας Α.Π.Θ.,Α΄ Ουρολογική Κλινική Α.Π.Θ. , Γ.Ν.Θ. «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ», Πρόεδρος Ελληνικής Ανδρολογικής Εταιρείας, Πρόεδρος Ουρολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος

Βούρος Ιωάννης
Ουρολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ, Ουρολογική Κλινική, Γ.Ν.Θ. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

Γάτσος Σωτήριος
Ουρολόγος, Ακαδημαϊκός Υπότροφος Β' Ουρολογική Α.Π.Θ., Γ.Ν.Θ. «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ»

Γιαννάκης Ιωάννης
Χειρουργός - Ουρολόγος

Γκοράνης Θεόδωρος
Χειρουργός - Ουρολόγος, Διευθυντής Ουρολογικής Κλινικής, Γ.Ν.ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

Γραικός Κωνσταντίνος
Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Ουρολογικό Ογκολογικό Τμήμα, Α.Ν.Θ. «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ»

Δημητριάδης Γεώργιος
Καθηγητής Ουρολογίας Α.Π.Θ., Διευθυντής Α΄ Ουρολογικής Κλινικής Α.Π.Θ. , Γ.Ν.Θ.«Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»

Διονυσόπουλος Δημήτριος
Παθολόγος-Ογκολόγος, Επιμελητής Α', Κλινική Παθολογικής Ογκολογίας Α.Π.Θ., Γ.Ν.Θ.«ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ»

Ζαρκαδούλιας Αδάμ
Επιμελητής Α', Ουρολογική Κλινική Γ.Ν.Θ.«ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»

Ζάχος Ιωάννης
Χειρουργός - Ουρολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ, Ουρολογική Κλινική, Π.Γ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ

Καζάνας Κοσμάς
Ουρολόγος, Διευθυντής Ουρολογικού Τμήματος Γ.Ν.ΒΕΡΟΙΑΣ

Καλαϊτζής Χρήστος
Καθηγητής Ουρολογίας, Διευθυντής Ουρολογικής Κλινικής Δ.Π.Θ., Π.Γ.Ν.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Καλινδέρης Νικόλαος
Ουρολόγος, Επιμελητής Α', Β' Ουρολογική Κλινική Α.Π.Θ., Γ.Ν.Θ. «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ»

Καλογεράς Νικόλαος
Ουρολόγος, Επιμελητής Α', Ουρολογική Κλινική, Γ.Ν.Θ. «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»

Κόλβατζης Μερκούριος
Ουρολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης Β' Ουρολογικής Κλινικής Α.Π.Θ., Γ.Ν.Θ. «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ»

προεδρείο - επιτροπές

Κολιάκος Νικόλαος
Ουρολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης Β' Ουρολογικής Κλινικής Α.Π.Θ., Γ.Ν.Θ. «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ»

Κουκουρίκης Περικλής
Ουρολόγος, Ακαδημαϊκός Υπότροφος Β' Ουρολογική Α.Π.Θ., Γ.Ν.Θ. «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ»

Κωνστάντουρα Μαρία
Φοιτήτρια, 4ο έτος, Τμήμα Ιατρικης Α.Π.Θ.

Μπτσογιαννης Ηρακλής
Αναπληρωτής Καθηγητής Ουρολογίας Ε.Κ.Π.Α., Β' Πανεπιστημιακή Ουρολογική Κλινική, Γ.Ν.Α.«ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»

Μοραλίδης Ευστράτιος
Καθηγητής Πυρηνικής Ιατρικής Α.Π.Θ., Γ΄Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής Ιατρικού Τμήματος Α.Π.Θ., Π.Γ.Ν.Θ.«ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ»

Μουρτζίλας Ευάγγελος
Ουρολόγος, Επιμελητής Α', Ουρολογική Κλινική, Γ.Ν.Θ. «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»

Μουστάκας Γεώργιος
Ουρολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ, Ουρολογική Κλινική, Α.Ν.Θ. «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ»

Μπαλάρης Βασίλειος
Πυρηνικός Ιατρός, Επιμελετής Α', Γ΄Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής Ιατρικού Τμήματος Α.Π.Θ., Π.Γ.Ν.Θ.«ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ»

Μυκονιάτης Ιωάννης
Χειρουργός - Ουρολόγος, Ακαδημαϊκός Υπότροφος, Α' Ουρολογική Κλινική Α.Π.Θ., Γ.Ν.Θ. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ», Reader Ανατομίας, Εργαστήριο Ανατομίας και Χειρουργικής Ανατομίας, Α.Π.Θ.

Μυτιλέκας Κωνσταντίνος-Βάιος
Ουρολόγος Ακαδημαϊκός Υπότροφος Α.Π.Θ., Β' Ουρολογική Κλινική Α.Π.Θ., Γ.Ν.Θ. «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ»

Μωυσίδης Κυριάκος
Χειρουργός - Ουρολόγος, Επίκουρος Καθηγητής Ουρολογίας Α.Π.Θ, Β' Ουρολογική Κλινική Α.Π.Θ., Γ.Ν.Θ. «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ»

Παπαευσταθίου Ευστάθιος
Στρατιωτικός Ιατρός- Ουρολόγος Κεντρο Εκπαίδευσης Πυροβολικού - 401 ΓΣΝΑ

Παπαθανασίου Μιχαήλ
Ουρολόγος, Διευθυντής Ουρολογικής Κλινικής, 424 Γ.Σ.Ν.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Παπαλάκης Απόστολος
Ουρολόγος, Διευθυντής Ουρολογικού Τμήματος, Γ.Ν.Θ. «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»

Παπανικολάου Δημήτριος
Ουρολόγος, Ακαδημαϊκός Υπότροφος Β' Ουρολογική Α.Π.Θ., Γ.Ν.Θ. «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ»

Πάτρης Εμμανουήλ
Ουρολόγος, Διευθυντής Ουρολογικής Κλινικής Ε.Σ.Υ, Π.Γ.Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Σαββάκης Σταύρος
Φοιτητής, 4ο έτος, Τμήμα Ιατρικης Α.Π.Θ.

Σακαλής Βασίλειος
Ουρολόγος, Επιμελητης Ά, Ουρολογική Κλινική, Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»

Σαμαρίνας Μιχαήλ
Ουρολόγος, Επιμελητής Β' Ουρολογικής Κλινικής, Γ.Ν. Λάρισας, Head of the Urodynamics Unit, Γ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ

Σάρρα Σοφία-Ηλέκτρα
Φοιτήτρια, 4ο έτος, Τμήμα Ιατρικης Α.Π.Θ.

Σαχπεκίδης Χρήστος
Πυρηνικός Ιατρός, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Χαϊδελβέργης, Γερμανικό Κέντρο Έρευνας του Καρκίνου, Χαϊδελβέργη, Γερμανία

Σκριάπας Κωνσταντίνος
Χειρουργός - Ουρολόγος, Διευθυντής Ουρολογικής Κλινικής, Γ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ

Σοκολάκης Ιωάννης
Χειρουργός - Ουρολόγος, Επίκουρος Καθηγητής Ουρολογίας Α.Π.Θ, Β' Ουρολογική Κλινική Α.Π.Θ., Γ.Ν.Θ. «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ»

Σουντουλίδης Πέτρος
Επίκουρος Καθηγητής Ουρολογίας Α.Π.Θ., Α' Ουρολογική Κλινική Α.Π.Θ., Γ.Ν.Θ. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»

Τεζαψίδου Δήμητρα
Φοιτήτρια, 4ο έτος, Τμήμα Ιατρικης Α.Π.Θ.

Τζώρτζης Βασίλειος
Καθηγητής Ουρολογίας, Διευθυντής Πανεπιστημιακής Ουρολογικής Κλινικής, Π.Γ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ

Τσακαλδήμης Γεώργιος
Επίκουρος Καθηγητής Ουρολογίας Δ.Π.Θ., Π.Γ.Ν.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Φράγκος Μιχαήλ
Φοιτητής, 4ο έτος, Τμήμα Ιατρικης Α.Π.Θ.

Χατζημουρατίδης Κωνσταντίνος
Καθηγητής Ουρολογίας Α.Π.Θ., Διευθυντής Β' Ουρολογικής Κλινικής Α.Π.Θ., Γ.Ν.Θ.«ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ»

γενικές πληροφορίες

Τόπος Διεξαγωγής

Ξενοδοχείο Makedonia Palace

Λεωφ. Μεγ. Αλεξάνδρου 2, 54640 Θεσσαλονίκη

Τ: 2310897197

Ημερομηνίες

Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2022

Σάββατο 17 Δεκεμβρίου 2022

Κυριακή 18 Δεκεμβρίου 2022

Τρόπος Διεξαγωγής Συνεδρίου

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί μόνο με φυσική παρουσία

Ιστοσελίδα Συνεδρίου

www.ur-congress.gr

Διαμονή

Για την κάλυψη των αναγκών του Συνεδρίου έχει εξασφαλιστεί επαρκής αριθμός δωματίων στο ξενοδοχείο Makedonia Palace. Για πληροφορίες και κρατήσεις επικοινωνήστε με το Γραφείο Οργάνωσης

Έκθεση Προϊόντων

Κατά την διάρκεια του Συνεδρίου θα λειτουργήσει έκθεση προϊόντων φαρμακευτικών εταιρειών και εταιρειών ιατρικού εξοπλισμού

Μοριοδότηση

Στο 11ο Ετήσιο Ουρολογικό Συνέδριο, ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος θα χορηγήσει 13 Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (Σ.Ι.Ε. – CME-CPD)

Βεβαίωση Παρακολούθησης

Οι Βεβαιώσεις Παρακολούθησης θα δοθούν από το Γραφείο Οργάνωσης του συνέδριου. Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΕΟΦ (64740/01-09-2013) απαιτείται η παρακολούθηση του 60% των ωρών του Συνεδρίου

Τεχνική Γραμματεία

Οι ομιλητές παρακαλούνται να παραδίδουν τις διαφάνειες (slides), τα CD, τα DVD, και τα USB με τις ομιλίες τους στην Τεχνική Γραμματεία που θα λειτουργεί έξω από την αίθουσα συνεδριάσεων, τουλάχιστον μισή ώρα πριν την παρουσίασή τους

Γραφείο Εγγραφών

Παραλαβή Συνεδριακού Υλικού Η Γραμματεία του Συνεδρίου θα λειτουργεί:

Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2022
(ώρες 16:00 – 21:30)

Σάββατο 17 Δεκεμβρίου 2022
(ώρες 08:30 – 14:00 & 17:30 – 21:00)

Κυριακή 18 Δεκεμβρίου 2022
(ώρες 09:00 – Λήξη)

Γραφείο Οργάνωσης

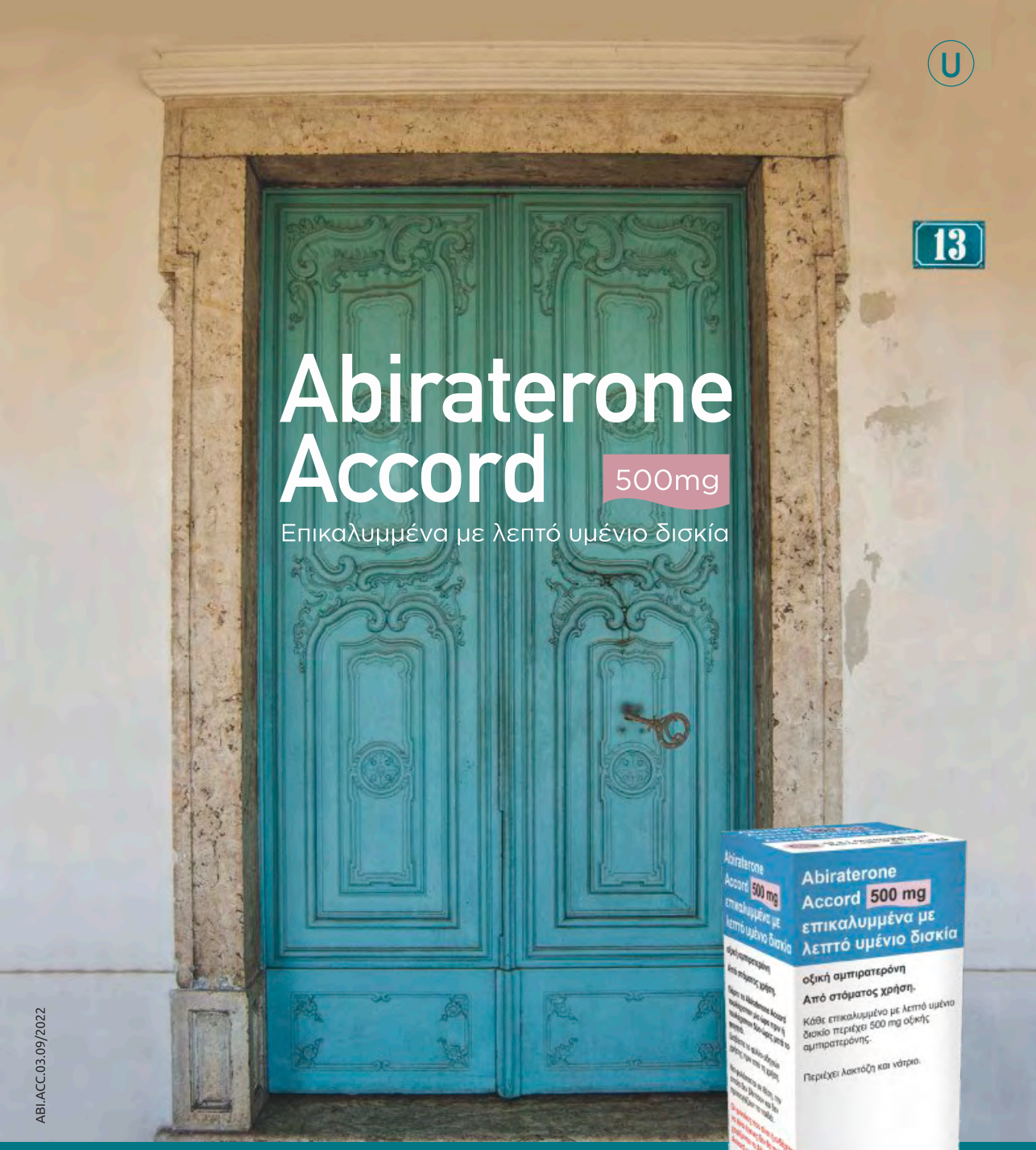
VOYAGER TRAVEL AND CONGRESS

Βασ. Ηρακλείου 26, 54624, Θεσσαλονίκη

Τ: +30 2310 250401 F: +30 2310 250418

E-mail: congress-secretary@voyagertravel.gr

www.voyagertravel.gr



ABI.ACC.03.09/2022

Νοσοκομειακή Τιμή: ABIRATERONE ACCORD F.C.TAB 500MG/TAB 60 X 1 ΔΙΣΚΙΑ ΜΙΑΣ ΔΟΣΗΣ ΣΕ BLISTERS PVC/PVDC/ALU: 1.923,13€

Πριν την συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος Abiraterone Accord, 04/2021

WinMedica
Serving Health for Life

Για περισσότερες πληροφορίες:
WIN MEDICA ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
Οιδίποδος 1-3 & Παράδρομος
Αττικής Οδού 33-35, 15238 Χαλάνδρι
Τηλ.: 2107488821, Fax: 2107488827
info@winmedica.gr, **www.winmedica.gr**

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

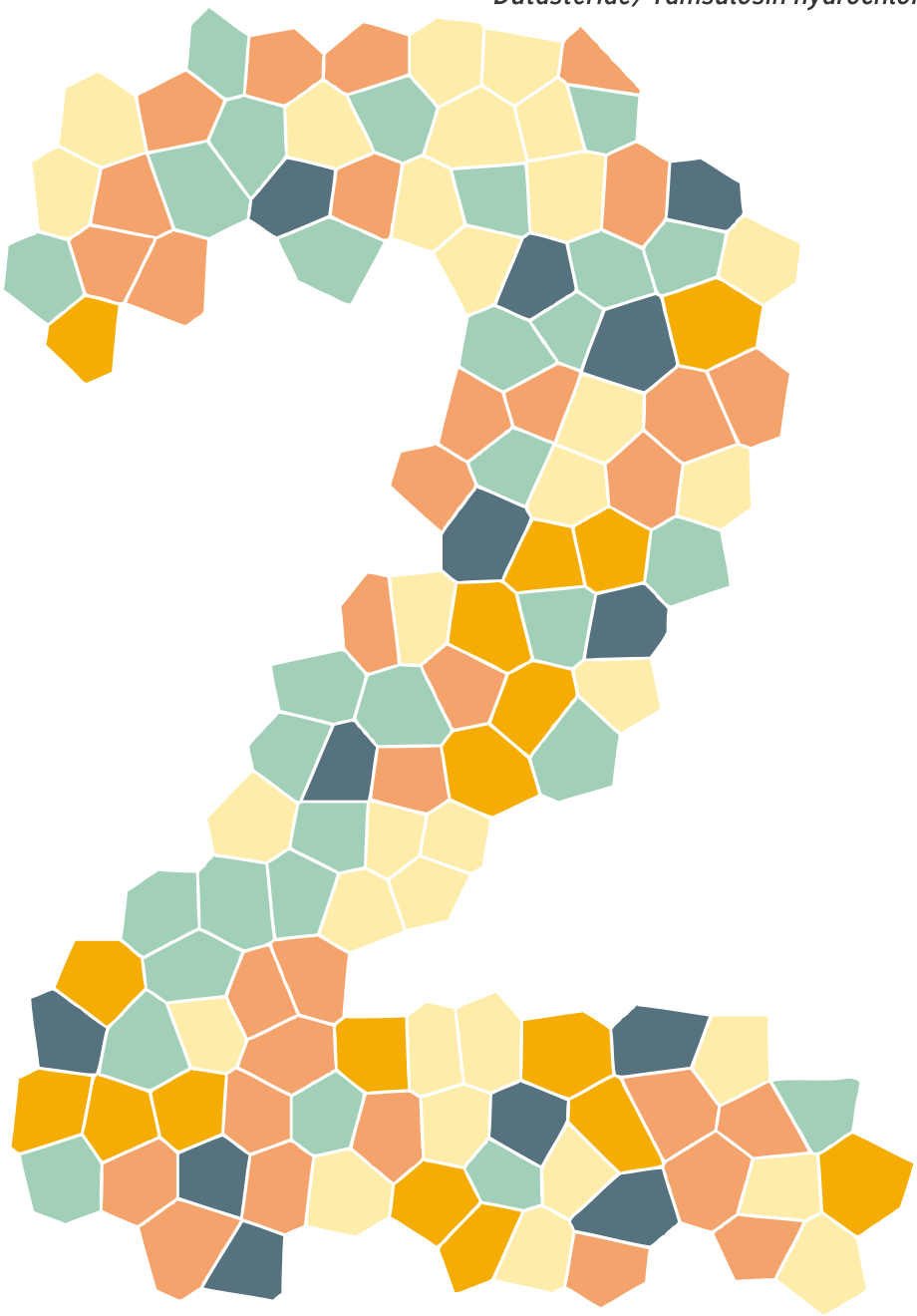
Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας: ***Accord Healthcare S.L.U.***

accord
We make it better

Winner

DYOSTER®

Dutasteride/Tamsulosin hydrochloride



ADV/DYO/03/07.2022

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και αναφέρετε όλες τις ανεπιθύμητες ενέργειες για όλα τα φάρμακα συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Χορηγείται με ιατρική συνταγή

Λ.Τ. DYOSTER 0,5MG/0,4MG, BTx30: 14,23 €

RAFARM

RAFARM A.E.B.E. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Κορίνθου 12, 15451 Ν. Ψυχικό, Αθήνα
Τηλ.: 211 176 1000 e-mail: info@rafarm.gr www.rafarm.gr

Για συνταγογραφικές πληροφορίες επικοινωνήστε στα τηλέφωνα της εταιρείας ή συμβουλευθείτε την Π.Χ.Π. σαρώνοντας το **QR code**

πρόγραμμα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022

14:00 – 18:00 **Εκπαίδευση σε εξομοιωτές ουρολογικών επεμβάσεων**
(κλειστά μαθήματα)

17:30 – 18:00 **Καφές Υποδοχής**

18:00 – 19:30 **Κλινικό Φροντιστήριο Πυρηνικής Ιατρικής**

Προεδρείο: **Καλαϊτζής Χρήστος, Τζώρτζης Βασίλειος**

Η Πυρηνική Ιατρική στη διάγνωση και αντιμετώπιση του καρκίνου του προστάτη
Άρσος Γεώργιος

Σπινθηρογράφημα οστών
Μπαλάρης Βασίλειος

Τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων (PET)
Μοραλίδης Ευστράτιος

Theranostics
Σαχπεκίδης Χρήστος

19:30 – 20:00 **Δορυφορική Διάλεξη 1**

ELPEN

Προεδρείο: **Μωυσίδης Κυριάκος**

Σύγχρονες θεραπευτικές προσεγγίσεις των λοιμώξεων του ουροποιητικού συστήματος με φάρμακα φυτικής προέλευσης
Σοκολάκης Ιωάννης

20:00 – 21:00 **Δορυφορικό Συμπόσιο**

janssen Oncology
PHARMACEUTICAL COMPANIES OF Johnson&Johnson

Προεδρείο: **Χατζημουρατίδης Κωνσταντίνος**

Απαντήσεις σε καθημερινά ερωτήματα στον μη μεταστατικό ευνουχοάντοχο (MOCRPC) και στο μεταστατικό ορμονοευαίσθητο καρκίνο του προστάτη (mHSPC).

Μη μεταστατικός ευνουχοάντοχος καρκίνος του προστάτη
Σοκολάκης Ιωάννης

Μεταστατικός ορμονοευαίσθητος καρκίνος του προστάτη
Διονυσόπουλος Δημήτριος

21:00 – 21:30 **Cocktail Υποδοχής**

ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022

09:00 – 11:30 Λειτουργική Ουρολογία

Συντονιστές: **Αποστολίδης Απόστολος, Μητσογιάννης Ηρακλής**

09:00 – 10:00 **Διαδραστικό σεμινάριο 1**

Ανδρικά LUTS: αρκεί ο βασικός διαγνωστικός έλεγχος για να χειρουργήσουμε ασθενή με καλοήθη υπερπλασία του προστάτη;

09:00 – 09:15 Υπέρ του βασικού ελέγχου
Σακαλής Βασίλειος

09:15 – 09:30 Υπέρ του ουροδυναμικού ελέγχου
Μυτιλέκας Κωνσταντίνος-Βάιος

09:30 – 10:00 Διαδραστική συζήτηση με αφορμή πραγματικό περιστατικό

10:00 – 11:00 **Διαδραστικό σεμινάριο 2**

Σύνδρομο επώδυνης ουροδόχου κύστης: διαγνωστικές και θεραπευτικές προκλήσεις

10:00 – 10:15 Προκλήσεις στη διαγνωστική
Γάτσος Σωτήριος

10:15 – 10:30 Θεραπευτικές προκλήσεις
Σαμαρίνας Μιχαήλ

10:30 – 11:00 Διαδραστική συζήτηση με αφορμή πραγματικό περιστατικό

11:00 – 11:30 **Σεμινάριο 3**

Λειτουργική Ουρολογία – από το πάγκο του εργαστηρίου στο μέλλον της κλινικής πράξης

11:00 – 11:15 Υπερλειτουργική κύστη
Κουκουρίκης Περικλής

11:15 – 11:30 Πυελική ισχαιμία/LUTS
Παπαευσταθίου Ευστάθιος

11:30 – 12:00 Διάλειμμα – Καφές

12:00 – 12:30 **Δορυφορική Διάλεξη 2**

IPSEN Innovation for patient care

Προεδρείο: **Παπαλάκης Απόστολος, Χατζημουρατίδης Κωνσταντίνος**

Ανδρογονικός αποκλεισμός στον καρκίνο του προστάτη: νεότερα δεδομένα
Μωυσίδης Κυριάκος

12:30 – 13:00 **Δορυφορική Διάλεξη 3**

astellas

Προεδρείο: **Χατζημουρατίδης Κωνσταντίνος**

Μεταστατικός ορμονοευαίσθητος καρκίνος του προστάτη (mHSPC): Μεταφράζοντας το όφελος επιβίωσης από τις κλινικές μελέτες στην κλινική πράξη
Σκριάπας Κωνσταντίνος

13:00 – 13:30 **Δορυφορική Διάλεξη 4**

AMGEN®

Προεδρείο: **Σουντουλίδης Πέτρος**

Η σημασία της πρόληψης των οστικών συμβαμάτων σε ασθενείς με ευνουχοάντοχο καρκίνο του προστάτη και οστική νόσο.
Καλογεράς Νικόλαος

13:30 – 14:00 **Δορυφορική Διάλεξη 5**

Bayer

Προεδρείο: **Μουστάκας Γεώργιος**

Δεύτερης (2ης) γενιάς αναστολείς ανδρογονικών υποδοχέων στον καρκίνο του προστάτη: παρόν και μέλλον
Καλογεράς Νικόλαος

14:00 – 18:00 **Εκπαίδευση σε εξομοιωτές ουρολογικών επεμβάσεων**
(κλειστά μαθήματα)

17:30 – 18:00 **Διάλειμμα – Καφές**

ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022

18:00 – 19:00 Μύθοι και πραγματικότητα σε ουρολογικές παθήσεις

Προεδρείο: **Παπαθανασίου Μιχαήλ, Γκοράνης Θεόδωρος**

18:00 – 18:15 Ουρολιθίαση
Γιαννάκης Ιωάννης

18:15 – 18:30 Καρκίνος του προστάτη
Γραικός Κωνσταντίνος

18:30 – 18:45 Καλοήθης υπερπλασία προστάτη
Καζάνας Κοσμάς

18:45 – 19:00 Λειτουργική ουρολογία
Γάτσος Σωτήριος

19:00 – 20:00 Εφιάλτες στην Ουρολογία

Προεδρείο: **Βακαλόπουλος Ιωάννης, Πάτρης Εμμανουήλ**

19:00 – 19:15 Επεμβάσεις έξω γεννητικών οργάνων
Μυκονιάτης Ιωάννης

19:15 – 19:30 Διαδερμικές και ουρητηροσκοπικές επεμβάσεις
Τσακαλδήμης Γεώργιος

19:30 – 19:45 Λαπαροσκοπικές επεμβάσεις
Ζάχος Ιωάννης

19:45 – 20:00 Χρήση νεότερων πηγών ενέργειας
Ζαρκαδούλιας Αδάμ

20:00 – 21:00 Tips & Tricks στην Ουρολογία

Προεδρείο: **Δημητριάδης Γεώργιος, Βούρος Ιωάννης**

20:00 – 20:15 Ριζική προστατεκτομή
Κολιάκος Νικόλαος

20:15 – 20:30 Βιοψία του προστάτη
Παπανικολάου Δημήτριος

20:30 – 20:45 Ουρητηροσκόπηση – Λιθοτριψία
Κόλβατζης Μερκούριος

20:45 – 21:00 Διουρηθρικές επεμβάσεις
Μουρτζίλας Ευάγγελος

ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022

09:30 – 15:00 **Οι φοιτητές παρουσιάζουν**

Προεδρείο: **Μωυσίδης Κυριάκος, Καλινδέρης Νικόλαος**

Σακχαρώδης διαβήτης: Ένας ύπουλος εχθρός (και) για το ουρογεννητικό σύστημα

Διαβητική νεφροπάθεια: Μια σοβαρή απειλή για τους νεφρούς
Φράγκος Μιχαήλ

Σακχαρώδης διαβήτης: Ένας επιβαρυντικός παράγοντας για την ουροδόχο κύστη
Τεζαψίδου Δήμητρα

Ουρολοιμώξεις και σακχαρώδης διαβήτης: Συνδέονται μεταξύ τους;
Σαββάκης Σταύρος

Σακχαρώδης διαβήτης: Ένοχος και για γυναικεία σεξουαλική δυσλειτουργία
Κωνστάντουρα Μαρία

Ο σακχαρώδης διαβήτης ως παράγοντας παρεμπόδισης της ανδρικής σεξουαλικής λειτουργίας
Σάρρα Σοφία-Ηλέκτρα

15:00 **Επίδοση βεβαιώσεων παρακολούθησης – Αξιολόγηση**

ευρετήριο

Α

Αποστολίδης Απόστολος.....14
Άρσος Γεώργιος.....13

Β

Βακαλόπουλος Ιωάννης.....16
Βούρος Ιωάννης.....16

Γ

Γάτσος Σωτήριος.....14,16
Γιαννάκης Ιωάννης.....16
Γκοράνης Θεόδωρος.....16
Γραικός Κωνσταντίνος.....16

Δ

Δημητριάδης Γεώργιος.....16
Διονυσόπουλος Δημήτριος.....13
Ζαρκαδούλιας Αδάμ.....16

Ζ

Ζάχος Ιωάννης.....16

Κ

Καζάνας Κοσμάς.....16
Καλαϊτζής Χρήστος.....13
Καλινδέρης Νικόλαος.....17
Καλογεράς Νικόλαος.....15
Κόλβατζης Μερκούριος.....16
Κολιάκος Νικόλαος.....16
Κουκουρίκης Περικλής.....14
Κωνστάντουρα Μαρία.....17

Μ

Μητσογιάννης Ηρακλής.....14
Μοραλίδης Ευστράτιος.....13
Μουρτζίλας Ευάγγελος.....16
Μουστάκας Γεώργιος.....15
Μπαλάρης Βασίλειος.....13
Μυκονιάτης Ιωάννης.....16
Μυτιλέκας Κωνσταντίνος-Βάιος
.....14
Μωυσίδης Κυριάκος.....13,15,17

Π

Παπαευσταθίου Ευστάθιος.....14
Παπαθανασίου Μιχαήλ.....16
Παπαλάκης Απόστολος.....15
Παπανικολάου Δημήτριος.....16
Πάτρης Εμμανουήλ.....16

Σ

Σαββάκης Σταύρος.....17
Σακαλής Βασίλειος.....14
Σαμαρίνας Μιχαήλ.....14
Σάρρα Σοφία - Ηλέκτρα.....17
Σαχπεκίδης Χρήστος.....13
Σκριάπας Κωνσταντίνος.....15
Σοκολάκης Ιωάννης.....13
Σουντουλίδης Πέτρος.....15

Τ

Τεζαψίδου Δήμητρα.....17
Τζώρτζης Βασίλειος.....13
Τσακαλδήμης Γεώργιος.....16

Φ

Φράγκος Μιχαήλ.....17

Χ

Χατζημουρατίδης Κωνσταντίνος.
.....13,15

Με το Arvekap®
μπορείς να αλλάξεις θέμα συζήτησης

Arvekap® 22.5mg
triptorelin

Έχεις τον **ΕΛΕΓΧΟ** του καρκίνου του προστάτη

ΜΙΛΗΣΕ για όσα έχουν αξία για τον άνδρα

Arvekap®: Προσφέρει τη δυνατότητα υποστήριξης και άλλων αναγκών του άνδρα.*

Οι περιεκτικότητες 1, 3 και 6 μηνών του Arvekap® ήταν καλά ανεκτές[1-7] και μείωσαν σημαντικά τα συμπτώματα από το Κατώτερο Ουροποιητικό Σύστημα (LUTS) σε διάστημα 48 εβδομάδων.[8]

Η 6μηνη μορφή του Arvekap®, ανταποκρίνεται στη συχνότητα των ενέσεων που προτιμούν οι άνδρες με καρκίνο του προστάτη.[9]

*Η μείωση του αριθμού των ενέσεων λόγω της τιτλοποίησης στην 6μηνη μορφή του Arvekap από σκεύασμα αγωνιστή LHRH μηνιαίας ή 3μηνιαίας διάρκειας, οδήγησε σε εξοικονόμηση χρόνου αντίστοιχου με 35,1 λεπτά ανά ασθενή (n=41).[3]

1. Heyns C, Simonin M, Grosgurin P, et al. BJU Int. 2003;92(3):226–231. **2.** Teillac P, Heyns C, Kaisary A, et al. Horm Res. 2004;62(5):252–258. **3.** Lundström EA, Rencken RK, van Wyk JH, et al. Clin Drug Investig. 2009;29(12):757–765. **4.** Arvekap® 22.5 mg. Summary of product characteristics, IPSEN MON. ΕΠΕ. **5.** Arvekap® 3.75 mg Summary of product characteristics, IPSEN MON. ΕΠΕ. **6.** Arvekap® 11.25 mg Summary of product characteristics, IPSEN MON. ΕΠΕ. **7.** Merseburger AS, Hupe MC. Adv Ther. 2016;33(7):1072–1093. **8.** Gil T, Aoun F, Cabri P, et al. Ther Adv Urol. 2015;7(3):116–124. **9.** Schulman C. BJU Int. 2007;100(Suppl. 1):6–11.

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος που βρίσκεται σε επόμενες σελίδες.
Τ.Π.: 425,32€ • Λ.Τ: 498,77€ • Δ.Τ.Φ.: 23/12/2021

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

IPSEN MON.ΕΠΕ
Αγ. Δημητρίου 63, 174 56 ΑΛΙΜΟΣ
Τηλέφωνο: 210 98 43 324, 210 98 58 930 & 210 98 58 940
Φαξ: 210 98 87 911
E-mail: ipsenepe@ipsen.com
http://www.ipsen.gr

IPSEN Innovation for patient care

10 ARV 11,25/3,75/22,5-Β/ΙΟΥΛ 2022.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: Arvekap 22,5 mg κόνις και διαλύτης για ενέσιμο εναιώρημα παρατεταμένης απελευθέρωσης. **2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:** Κάθε φιαλίδιο περιέχει triptorelin embonate που αντιστοιχεί σε 22,5 mg τριπτορελίνης. Μετά την αναδιάταση με 2 mL διαλύτη, 1 ml αναδυσταθέντος εναιωρήματος περιέχει 11,25 mg τριπτορελίνης. Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ. παράγραφο 6.1. **3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ:** Κόνις και διαλύτης για ενέσιμο εναιώρημα παρατεταμένης απελευθέρωσης. Κόνις: Λευκή έως ελαφρώς κίτρινη σκόνη. Διαλύτης: Διαυγές διάλυμα. **4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 4.1. Θεραπευτικές ενδείξεις:** Το Arvekap 22,5 mg ενδείκνυται για τη θεραπεία του τοπικά προχωρημένου ή μεταστατικού ορμονοεξαρτώμενου καρκίνου του προστάτη. Το Arvekap 22,5 mg ενδείκνυται για τη θεραπεία του υψηλού κινδύνου εντοπισμένου ή τοπικά προχωρημένου, ορμονοεξαρτώμενου καρκίνου του προστάτη σε συνδυασμό με την ακτινοθεραπεία. Βλ. παράγραφο 5.1. Το Arvekap 22,5 mg ενδείκνυται για τη θεραπεία της κεντρικής πρώιμης ήβης (CPP) σε παιδιά ηλικίας 2 ετών και άνω, με εμφάνιση της κεντρικής πρώιμης ήβης πριν από την ηλικία των 8 ετών στα κορίτσια και των 10 ετών στα αγόρια. **4.2. Δοσολογία και τρόπος χορήγησης:** Δοσολογία: Η συνιστώμενη δόση του Arvekap 22,5 mg είναι 22,5 mg τριπτορελίνη (1 φιαλίδιο) χορηγούμενο κάθε έξι μήνες (εικοσιτέσσερις εβδομάδες) ως μία ερήμαξ ενδομυϊκή έγχυση. Ως συγχορηγούμενοι και ακόλουθοι της ακτινοθεραπείας στον υψηλού κινδύνου εντοπισμένο ή τοπικά προχωρημένο ορμονοεξαρτώμενο καρκίνο του προστάτη, κλινικά δεδομένα έχουν δείξει ότι η ακτινοθεραπεία, ακολουθούμενη από μακροχρόνια θεραπεία στέρησης ανδρογόνων είναι προτιμότερη από ακτινοθεραπεία ακολουθούμενη από βραχυχρόνια θεραπεία στέρησης των ανδρογόνων. Βλέπε παράγραφο 5.1. Η διάρκεια της θεραπείας στέρησης ανδρογόνων, η οποία συνιστάται από ιατρικές κατευθυντήριες οδηγίες για ασθενείς με υψηλού κινδύνου εντοπισμένο ή τοπικά προχωρημένο καρκίνο του προστάτη που λαμβάνουν ακτινοθεραπεία είναι 2-3 χρόνια.Σε ασθενείς με ανθεκτικό στον ευνουχισμό, μεταστατικό καρκίνο του προστάτη, μη χειρουργικά ευνουχισμένους, οι οποίοι λαμβάνουν κάποιον αγωνιστή GnRH, όπως η τριπτορελίνη και είναι επιλέξιμοι για θεραπεία με abiraterone acetate, έναν αναστολέα βιοσύνθεσης των ανδρογόνων ή με enzalutamide, έναν αναστολέα της λειτουργίας του ανδρογονικού υποδοχέα, η θεραπεία με τον αγωνιστή GnRH πρέπει να συνεχιστεί. *Ασθενείς με επηρεασμένη νεφρική ή ηπατική δυσλειτουργία:* Δεν απαιτείται προσαρμογή της δοσολογίας για ασθενείς με νεφρική ή ηπατική ανεπάρκεια. *Παιδιατρικός πληθυσμός:* **Πρώιμη ήβη (πριν από την ηλικία των 8 ετών στα κορίτσια και των 10 ετών στα αγόρια).** Η θεραπεία παιδιών με το Arvekap 22,5 mg πρέπει να βρίσκεται κάτω από την συνολική επίβλεψη ενός παιδοενδοκρινολόγου ή παιδιάτρου ή ενδοκρινολόγου με εξειδίκευση στη θεραπεία της κεντρικής πρώιμης ήβης.Η θεραπεία θα πρέπει να διακοπεί όταν πληησιάζει η φυσιολογική ηλικία της ήβης στα αγόρια και τα κορίτσια και δεν θα πρέπει να συνεχίζεται σε κορίτσια με οστική ηλικία μεγαλύτερη των 12–13 ετών. Υπάρχουν περιορισμένα διαθέσιμα δεδομένα σε αγόρια σχετικά με τον άριστο χρόνο διακοπής της αγωγής βάσει της οστικής ηλικίας, ωστόσο προτείνεται η διακοπή της αγωγής σε αγόρια με οστική ηλικία 13-14 ετών. Τρόπος χορήγησης: Το σημείο της ένεσης θα πρέπει να εναλλάσσεται περιοδικά, όπως συμβαίνει και με άλλα ενέσιμα φαρμακευτικά προϊόντα. Μετά την αναδιάταση, το εναιώρημα του Arvekap 22,5 mg πρέπει να ενίεται σχετικά γρήγορα και με χωρίς διακοπή τρόπο, προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε πιθανή απόφραξη της βελόνας. *Προφυλάξεις που πρέπει να ληφθούν πριν από το χειρισμό ή την χορήγηση του φαρμακευτικού προϊόντος:* Το Arvekap 22,5 mg προορίζεται αποκλειστικά για ενδομυϊκή χορήγηση. Καθώς το Arvekap 22,5 mg είναι εναιώρημα μικροσφαιριδίων, ακούσια ενδοαγγειακή έγχυση πρέπει αυστηρά να αποφεύγεται. Το Arvekap 22,5 mg πρέπει να χορηγείται υπό την επίβλεψη ιατρού. Για οδηγίες σχετικά με την ανασύσταση του φαρμακευτικού προϊόντος πριν από τη χορήγηση, βλέπε παράγραφο 6.6. **4.3. Αντενδείξεις:** Υπερευαισθησία στην GnRH (εκλυτική ορμόνη των γοναδοτροπινών), τα ανάλογά της ή σε οποιοδήποτε από τα έκδοχα του φαρμακευτικού προϊόντος που αναγράφονται στην παράγραφο 6.1 (ανατρέξτε επίσης στην παράγραφο 4.8). *Η τριπτορελίνη αντενδείκνυται κατά τη διάρκεια της κύησης και της γαλουχίας (βλ. παράγραφο 4.6).* **4.4. Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση:** Η χρήση των GnRH αγωνιστών μπορεί να προκαλέσει μείωση της οστικής πυκνότητας. Στους άνδρες, προκαταρκτικά στοιχεία δείχνουν ότι η χρήση ενός διφωσφονικού σε συνδυασμό με έναν αγωνιστή GnRH μπορεί να μειώσει την απώλεια οστικής μάζας. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται σε ασθενείς με επιπρόσθετους παράγοντες κινδύνου για οστεοπόρωση (π.χ. χρόνια κατάχρηση αλκοόλ, καπνιστές, μακροχρόνια θεραπεία με φάρμακα που μειώνουν την οστική πυκνότητα, π.χ. αντιεπιληπτικά ή κορτικοειδή, οικογενειακό ιστορικό οστεοπόρωσης, υποσιτισμός). Σε σπάνιες περιπτώσεις, η θεραπεία με αγωνιστές GnRH μπορεί να αποκαλύψει την παρουσία προηγουμένως αδιάγνωστου αδενώματος γοναδοτρόπων κυττάρων της υπόφυσης. Αυτοί οι ασθενείς μπορεί να παρουσιάσουν αποπληξία της υπόφυσης η οποία χαρακτηρίζεται από αιφνίδια κεφαλαλγία, έμετο, διαταραχές της όρασης και οφθαλμοπληγία. Υπάρχει αυξημένος κίνδυνος εμφάνισης κατάθλιψης (η οποία μπορεί να είναι σοβαρή) σε ασθενείς που υποβάλλονται σε θεραπεία με GnRH ανάλογα, όπως η τριπτορελίνη. Εάν εμφανιστούν συμπτώματα οι ασθενείς πρέπει να ενημερώνονται δεόντως και να αντιμετωπίζονται κατάλληλα. Οι ασθενείς με γνωστή κατάθλιψη πρέπει να παρακολουθούνται στενά κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Απαιτείται προσοχή με την ενδομυϊκή έγχυση σε ασθενείς οι οποίοι λαμβάνουν αγωγή με αντιπηκτικά, λόγω πιθανού κινδύνου αιματωμάτων στο σημείο της ένεσης. Η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια του Arvekap 22.5 mg έχει τεκμηριωθεί μόνο μέσω της ενδομυϊκής οδού χορήγησης. Η υποδόρια χορήγηση δεν συνιστάται. Αυτό το φάρμακο περιέχει λιγότερο από 1 mmol (23mg) νατρίου ανά δόση, δηλαδή είναι ουσιαστικά «ελεύθερο νατρίου». Καρκίνος του προστάτη: Αρχικά, η τριπτορελίνη, όπως και άλλοι αγωνιστές GnRH, προκαλεί μια παροδική αύξηση των επιπέδων της τεστοστερόνης στον ορό. Ως συνέπεια, κατά τις πρώτες εβδομάδες της θεραπείας, μπορεί να εμφανιστούν περιστασιακά μεμονωμένες περιπτώσεις παροδικής επιδείνωσης των συμπτωμάτων του καρκίνου του προστάτη. Κατά την αρχική φάση της θεραπείας, πρέπει να εξετάστεί η πρόσθετη χορήγηση ενός κατάλληλου αντι-ανδρογόνου, ώστε να αντιμετωπιστεί η αρχική αύξηση των επιπέδων τεστοστερόνης στον ορό και η επιδείνωση των κλινικών συμπτωμάτων. Μικρός αριθμός ασθενών μπορεί να εμφανίσει παροδική επιδείνωση των σημείων και συμπτωμάτων του καρκίνου του προστάτη (έξαρση του όγκου) και παροδική αύξηση του πόνου που σχετίζεται με τον καρκίνο (μεταστατικός πόνος), ο οποίος μπορεί να αντιμετωπιστεί συμπτωματικά. Όπως και με άλλους αγωνιστές GnRH, έχουν παρατηρηθεί μεμονωμένες περιπτώσεις συμπίεσης του νωτιαίου μυελού ή απόφραξης της ουρήθρας. Αν εμφανιστεί συμπίεση νωτιαίου μυελού ή έκπτωση της νεφρικής λειτουργίας, πρέπει να χορηγηθεί η συνήθης θεραπεία για αυτές τις επιπλοκές και σε ακραίες περιπτώσεις να εξεταστεί η περίπτωση άμεσης ορχεκτομής (χειρουργικού ευνουχισμού). Κατά τη διάρκεια των πρώτων εβδομάδων θεραπείας ενδείκνυται προσεκτική παρακολούθηση, ιδιαίτερα σε ασθενείς με σπονδυλικές μεταστάσεις με κίνδυνο συμπίεσης του νωτιαίου μυελού και σε ασθενείς με απόφραξη των ουροφόρων οδών. Μετά από χειρουργικό ευνουχισμό, η τριπτορελίνη δεν επάγει περαιτέρω μείωση των επιπέδων της τεστοστερόνης στον ορό. Όταν επιτευχθούν επίπεδα ευνουχισμού για την τεστοστερόνη έως το τέλος του πρώτου μήνα, τα επίπεδα τεστοστερόνης στον ορό διατηρούνται για όσο διάστημα οι ασθενείς λαμβάνουν την ένσησ τους κάθε 6 μήνες (είκοσι τέσσερις εβδομάδες). Η αποτελεσματικότητα της θεραπείας μπορεί να παρακολουθείται με τη μέτρηση των επιπέδων της τεστοστερόνης στον ορό και του ειδικού προστατικού αντιγόνου. Η μακρόχρονη στέρηση ανδρογόνων είτε λόγω αμφίπλευρης ορχεκτομής ή λόγω χορήγησης αναλόγων GnRH σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο απώλειας οστικής μάζας και μπορεί να οδηγήσει σε οστεοπόρωση και αυξημένο κίνδυνο οστικού κατάγματος. Η θεραπεία στέρησης ανδρογόνων μπορεί να παρατείνει το διάστημα QT. Σε ασθενείς με ιστορικό ή με παράγοντες κινδύνου για παράταση του διαστήματος QT και σε ασθενείς οι οποίοι λαμβάνουν ταυτόχρονη θεραπεία με φαρμακευτικά προϊόντα τα οποία μπορεί να παρατείνουν το διάστημα QT (βλ. παράγραφο 4.5) οι γιατροί πρέπει να εξετάσουν το προφίλ οφέλους/κινδύνου περιλαμβανομένης της δυνατότητας για κοιλιακή ταχυκαρδία δίκην ρητιδίου (Torsades de pointes) πριν την έναρξη της θεραπείας με Arvekap 22,5mg. Επιπλέον, έχει παρατηρηθεί από επιδημιολογικά δεδομένα ότι ασθενείς κατά τη διάρκεια θεραπείας με στέρηση ανδρογόνων μπορεί να εμφανίσουν αλλαγές στο μεταβολισμό (π.χ. δυσανεξία στη γλυκόζη) ή αυξημένο κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων. Παρόλα αυτά, προοπτικά στοιχεία δεν επιβεβαιώνουν τη σχέση ανάμεσα στη θεραπεία με ανάλογα GnRH και την αύξηση της θνησιμότητας λόγω καρδιαγγειακών νοσημάτων. Ασθενείς με υψηλό κίνδυνο μεταβολικών ή καρδιαγγειακών παθήσεων πρέπει να αξιολογούνται προσεκτικά πριν την έναρξη της θεραπείας και να παρακολουθούνται επαρκώς κατά τη διάρκεια θεραπείας στέρησης ανδρογόνων. Η χορήγηση τριπτορελίνης σε θεραπευτικές δόσεις έχει ως αποτέλεσμα την καταστολή του υποφυσιακού γοναδιακού άξονα. Η φυσιολογική λειτουργία συνήθως αποκαθίσταται με τη διακοπή της θεραπείας. Επομένως, διαγνωστικοί έλεγχοι της υποφυσιακής γοναδιακής λειτουργίας οι οποίοι διεξάγονται κατά τη διάρκεια ή και μετά τη διακοπή της θεραπείας με ανάλογα GnRH μπορεί να είναι παραπλανητικοί. Πρώιμη ήβη: Η θεραπεία παιδικών με εξελισσόμενους εγκεφαλικούς όγκους θα πρέπει να ακολουθεί μία προσεκτική ατομική εκτίμηση των κινδύνων και των οφελών. Ψευδο-πρώιμη ήβη (όγκος γονάδων ή επινεφριδίων ή υπερπλασία επινεφριδίων) και πρώιμη ήβη που δεν εξαρτάται από γοναδοτροφίνες (τεστοτοξίκωση, οικογενειακή υπερπλασία των κυττάρων Leydig) θα πρέπει να αποκλείεται. Στα κορίτσια, η αρχική διέγερση των ωοθηκών κατά την έναρξη της θεραπείας, ακολουθούμενη από την απόσυρση των οιστρογόνων την οποία επάγει η θεραπεία, μπορεί κατά τον πρώτο μήνα να οδηγήσει σε κολπική αιμορραγία ήπιας ή μέτριας έντασης. Η θεραπεία είναι μια μακροχρόνια αγωγή, η οποία ρυθμίζεται ατομικά. Το Arvekap 22.5mg πρέπει να χορηγείται όσο το δυνατόν ακριβέστερα σε τακτικές 6 μηνιαίες περιόδους. Μια κατ' εξαίρεση καθυστέρηση της ημερομηνίας ένεσης για λίγες ημέρες (169 ± 3 ημέρες) δεν επηρεάζει τα αποτελέσματα της θεραπείας. Μετά τη διακοπή της θεραπείας θα εμφανιστεί ανάπτυξη των χαρακτηριστικών της εφηβείας. Οι πληροφορίες όσον αφορά την μελλοντική γονιμότητα εξακολουθούν να είναι περιορισμένες αλλά η μελλοντική αναπαραγωγική λειτουργία και η γονιμότητα φαίνεται να μην επηρεάζονται από τη θεραπεία με GnRH.. Στα περισσότερα κορίτσια, η τακτική έμμηνος ρήση θα ξεκινήσει κατά μέσο όρο ένα χρόνο μετά τον τερματισμό της θεραπείας. Η οστική πυκνότητα (BMD) μπορεί να μειωθεί κατά τη θεραπεία της κεντρικής πρώιμης ήβης με GnRH. Ωστόσο, μετά τη διακοπή της θεραπείας, η επακόλουθη αύξηση της οστικής μάζας διατηρείται και η μέγιστη οστική μάζα στα τέλη της εφηβείας δεν φαίνεται να επηρεάζεται από τη θεραπεία. Μπορεί να παρατηρηθεί επιφυσιολίσθηση μετά την απόσυρση της θεραπείας με GnRH. Η προτεινόμενη θεωρία είναι ότι οι χαμηλές συγκεντρώσεις οιστρογόνων κατά τη διάρκεια της θεραπείας με αγωνιστές GnRH εξασθενούν την επιφυσιακή πλάκα. Η αύξηση της ταχύτητας ανάπτυξης μετά τη διακοπή της θεραπείας οδηγεί στη συνέχεια σε μείωση της δύναμης διάτμησης που απαιτείται για τη μετατόπιση της επίφυσης. **4.5 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης:** Θα πρέπει να δίδεται προσοχή όταν η τριπτορελίνη συγχορηγείται με φάρμακα τα οποία επηρεάζουν την υποφυσιακή έκκριση των γοναδοτροφινών και συνιστάται να επιβλέπεται η ορμονική κατάσταση του ασθενούς. Επειδή η θεραπεία στέρησης ανδρογόνων μπορεί να παρατείνει το διάστημα QT, θα πρέπει να αξιολογείται προσεκτικά η ταυτόχρονη χρήση του Arvekap 22,5mg με φαρμακευτικά προϊόντα τα οποία είναι γνωστό ότι παρατείνουν το διάστημα QT ή φάρμακα που μπορούν να προκαλέσουν κοιλιακή ταχυκαρδία δίκην ρητιδίου (Torsades de pointes) όπως αντιαρρυθμικά φάρμακα τάξης IA (π.χ. κινιδίνη, δισοπυραμίδη) ή τάξης III (π.χ. αμιοδαρόνη, σοταλόλη, δοφετιλίδη, ιμπουτιλίδη), μεθαδόνη, μοξιφλοξασίνη, αντιψυχωτικά, κλη (βλ. παράγραφο 4.4). Παιδιατρικός πληθυσμός: Μελέτες αλληλεπιδράσεων έχουν πραγματοποιηθεί μόνο σε ενήλικες. **4.6 Γονιμότητα, Κύηση και Γαλουχία:** Κύηση: Η χρήση του Arvekap 22,5 mg ενδείκνυται σε ενήλικους άνδρες και σε παιδιά. Υπάρχουν πολύ περιορισμένα δεδομένα για τη χρήση της τριπτορελίνης σε εγκύους γυναίκες. Η χρήση του Arvekap 22,5 mg δεν ενδείκνυται σε γυναίκες. Πριν από τη συνταγογράφηση Arvekap 22,5 mg, θα πρέπει να επιβεβαιωθεί ότι η ασθενής δεν είναι έγκυος. Η τριπτορελίνη δεν πρέπει να χρησιμοποιείται κατά την κύηση καθώς η ταυτόχρονη χρήση των GnRH αγωνιστών συνδέεται με ένα θεωρητικό κίνδυνο αποβολής ή εμβρυϊκής ανωμαλίας. Πριν από τη θεραπεία, δυνητικά γόνιμες γυναίκες θα πρέπει να εξετάζονται προσεκτικά για να αποκλείεται η εγκυμοσύνη. Μέθοδοι μη ορμονικής αντισύλληψης πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια της θεραπείας μέχρι να επιστρέψει η εμμηνορροϊα. Μελέτες σε ζώα έχουν δείξει επιδράσεις σε αναπαραγωγικές παραμέτρους (βλ.παράγραφο 5.3 Προκλινικά στοιχεία ασφαλείας). Γαλουχία: Το Arvekap 22,5 mg είναι δεν ενδείκνυται σε θηλάζουσες γυναίκες. **4.7 Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανημάτων:** Δεν έχουν πραγματοποιηθεί μελέτες ως προς τις επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανημάτων. Η ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανημάτων μπορεί να επηρεαστεί εάν ο ασθενής αισθανθεί ζάλη, υπνηλία και οπτικές διαταραχές, οι οποίες αποτελούν πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες της θεραπείας ή απορρέουν από την υποκείμενη νόσο. **4.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες:** Γενικά αναφορά σε άνδρες: Καθώς οι ασθενείς με τοπικά προχωρημένο ή μεταστατικό, ορμονοεξαρτώμενο καρκίνο του προστάτη είναι γενικά ηλικιωμένοι και εμφανίζουν και άλλες παθήσεις, οι οποίες είναι συχνές στον πληθυσμό αυτής της ηλικίας, περισσότεροι από το 90% των ασθενών οι οποίοι συμμετείχαν σε κλινικές μελέτες ανέφεραν ανεπιθύμητες ενέργειες και επομένως συχνά είναι δύσκολο να εκτιμηθεί η αιτιότητα. Όπως έχει παρατηρηθεί με άλλες θεραπείες με αγωνιστές GnRH ή μετά από χειρουργικό ευνουχισμό, οι συχνότερα παρατηρούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες σχετικές με τη θεραπεία με τριπτορελίνη οφείλονταν στις αναμενόμενες φαρμακολογικές της επιδράσεις. Αυτές οι επιδράσεις περιλαμβανεν εξάψεις, στυτική δυσλειτουργία και μειωμένη γενετήσια επιθυμία. Με την εξαίρεση ανοσο-αλλεργικών αντιδράσεων (σπάνιες) και αντιδράσεων στο σημείο της ένεσης (< 5%), όλες οι ανεπιθύμητες ενέργειες είναι γνωστό ότι σχετίζονται με τις αλλαγές στα επίπεδα τεστοστερόνης. Αναφέρθηκαν οι ακόλουθες ανεπιθύμητες αντιδράσεις οι οποίες θεωρούνται τουλάχιστον πιθανώς σχετιζόμενες με τη θεραπεία με τριπτορελίνη. Οι περισσότερες από αυτές τις αντιδράσεις είναι γνωστό ότι συμβαίνουν με βιοχημικό ή χειρουργικό ευνουχισμό. Η συχνότητα των ανεπιθύμητων ενεργειών ταξινομείται ως εξής: *Πολύ συχνές (≥ 1/10), Συχνές (≥ 1/100, <1/10), Όχι συχνές (≥1/1000, <1/100), Σπάνιες (≥1/10000, <1/1000), Μη γνωστές (δεν μπορούν να εκτιμηθούν με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα).*

Κατηγορία Οργανικού Συστήματος	Πολύ Συχνές	Συχνές	Όχι Συχνές	Σπάνιες	Επιπλέον μετά την κυκλοφορία του προϊόντος Μη γνωστής συχνότητας
Διαταραχές του αιμοποιητικού και του λεμφικού συστήματος			Θρομβοκυττάρωση		
Καρδιακές διαταραχές			Αίσθημα παλμών		Παράταση διαστήματος QT* (βλ. παραγράφους 4.4 και 4.5)
Διαταραχές του ωτός και του λαβυρίνθου			Εμβοή Ίλιγγος		
Διαταραχές του ενδοκρινικού συστήματος					Αποπληξία της υπόφυσης**
Οφθαλμικές διαταραχές			Επηρεασμένη όραση	Μη φυσιολογική αίσθηση οφθαλμών, Διαταραχές όρασης	
Διαταραχές του γαστρεντερικού		Ξηροστομία, Ναυτία	Κοιλιακό άλγος, Δυσκοιλιότητα, Διάρροια, Έμετος	Διάταση κοιλίας, Αλλοίωση γεύσης, Μετεωρισμός	
Γενικές διαταραχές και καταστάσεις της οδού χορήγησης	Εξασθένηση	Αντίδραση στο σημείο της ένεσης (περιλαμβάνονται ερύθημα, φλεγμονή και Πόνος), Οίδημα	Λήθαργος, Περιφερικό οίδημα, Πόνος, Ρίγη, Υπνηλία	Πόνος στο στήθος, Διαταραχές στάσεως, Τριπτώδης συνδρομή, Πυρεξία	Κακουχία
Διαταραχές του ανοσοποιητικού		Υπερευαισθησία		Αναφυλακτική αντίδραση	Αναφυλακτικό σοκ
Λοιμώξεις και παρασιτώσεις				Ρινοφαρυγγίτιδα	
Παρακλινικές εξετάσεις		Αύξηση βάρους	Αμινοτρανσφεράση της αλανίνης αυξημένη, Ασπαρτική αμινοτρανσφεράση αυξημένη, Κρεατινίνη αίματος αυξημένη, Αρτηριακή πίεση αυξημένη, Ουρία αίματος αυξημένη, Γάμμα-γλουτα-μυλ-τρανσφεράση, αυξημένη, Βάρος μειωμένο	Αλκαλική φωσφατάση αίματος αυξημένη	
Διαταραχές του μεταβολισμού και της θρέψης			Ανορεξία, Σακχαρώδης διαβήτης, Ουρική αρθρίτιδα, Υπερλιπιδαιμία, Αυξημένη όρεξη		
Διαταραχές του μυοσκελετικού συστήματος και του συνδετικού ιστού	Οσφαλγία	Μυοσκελετικός πόνος, Πόνος στα άκρα	Αρθραλγία, Οστικός πόνος, Μυϊκή κράμπα, Μυϊκή αδυναμία, Μυαλγία	Δυσκαμψία αρθρώσεων, Διόγκωση αρθρώσεων, Μυοσκελετικά δυσκαμψία, Οστεοαρθρίτιδα	
Διαταραχές του νευρικού συστήματος	Παραισθησία κάτω άκρων	Ζάλη, Κεφαλαλγία	Παραισθησία	Επηρεασμένη μνήμη	
Ψυχιατρικές διαταραχές	Γενετήσια επιθυμία μειωμένη	Απώλεια γενετήσιας επιθυμίας Κατάθλιψη*, Αλλαγές της διάθεσης*	Αϋπνία, Ευερεθιστότητα	Συγχυτική, Κατάσταση, Μειωμένη δραστηριότητα, Ευφορική διάθεση	Άγχος
Διαταραχές των νεφρών και των ουροφόρων οδών			Νυκτουρία, Κατακράτηση ούρων		Ακράτεια ούρων
Διαταραχές του αναπαραγωγικού συστήματος και του μαστού	Στυτική δυσλειτουργία (περιλαμβάνονται αποτυχία εκσπερμάτισης, διαταραχή εκσπερμάτισης)	Πυελικός πόνος	Γυναικομαστία, Πόνος στον μαστό, Ατροφία όρχεων, Πόνος στους όρχεις		
Διαταραχές του αναπνευστικού συστήματος, του θώρακα και του μεσοθωράκιου			Δύσπνοια, Επίσταξη	Ορθόπνοια	
Διαταραχές του δέρματος και του υποδορίου ιστού	Υπεριδρωσία		Ακμή, Αλωπεκία, Εξάνθημα, Κνησμός, Εξάνθημα, Κνίδωση	Φυαλίδα Πορφύρα	Αγγειονευρωτικό οίδημα

Αγγειακές διαταραχές	Εξάψεις	Υπέρταση		Υπόταση	

*Αυτή η συχνότητα βασίζεται σε συχνότητες της κατηγορίας αυτής των φαρμάκων (class-effect), κοινές για όλους τους GnRH αγωνιστές
**Αναφέρθηκε μετά την αρχική χορήγηση σε ασθενείς με αδένωμα της υπόφυσης

Η τριπτορελίνη, μέσα στην πρώτη εβδομάδα μετά την αρχική έναρξη της μορφής παρατεταμένης αποδέσμευσης, προκαλεί παροδική αύξηση των επιπέδων της τεστοστερόνης στην κυκλοφορία. Με αυτή την αρχική αύξηση των επιπέδων τεστοστερόνης στην κυκλοφορία, ένα μικρό ποσοστό ασθενών (≤ 5%) μπορεί να εμφανίσει προσωρινή επιδείνωση των συμπτωμάτων του καρκίνου του προστάτη (έξαρση του όγκου), η οποία συνήθως εκδηλώνεται με αύξηση των συμπτωμάτων στο ουροποιητικό (< 2%) και του μεταστατικού πόνου (5%), τα οποία μπορούν να αντιμετωπιστούν συμπτωματικά. Αυτά τα συμπτώματα είναι παροδικά και συνήθως εξαφανίζονται σε μία έως δύο εβδομάδες. Έχουν προκύψει μεμονωμένες περιπτώσεις όξυνσης συμπτωμάτων της ασθένειας, είτε απόφραξη ουρήθρας ή συμπίεση νωτιαίου μυελού λόγω μετάστασης. Επομένως, ασθενείς με μεταστατικές σπονδυλικές βλάβες και/ ή απόφραξη των άνω ή κάτω ουροφόρων οδών θα πρέπει να παρακολουθούνται στενά κατά τη διάρκεια των πρώτων εβδομάδων της θεραπείας (βλέπε παράγραφο 4.4. Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση). Η χρήση GnRH αγωνιστών στη θεραπεία του καρκίνου του προστάτη μπορεί να σχετίζεται με αυξημένη απώλεια οστικής μάζας και μπορεί να οδηγήσει σε οστεοπόρωση και να αυξήσει τον κίνδυνο οστικού κατάγματος. Αυτά επίσης μπορεί οδηγήσει σε λανθασμένη διάγνωση οστικών μεταστάσεων. Οι ασθενείς που λαμβάνουν μακροχρόνια θεραπεία με ανάλογο GnRH σε συνδυασμό με ακτινοθεραπεία μπορεί να έχουν περισσότερες ανεπιθύμητες ενέργειες, κυρίως γαστρεντερικές και σχετιζόμενες με την ακτινοθεραπεία. *Ξενική αναφορά σε παιδιά (βλ. παράγραφο 4.4):* Η συχνότητα των ανεπιθύμητων ενεργειών ταξινομείται ως εξής: *Πολύ συχνές (≥ 1/10), Συχνές (≥ 1/100 , < 1/10), Όχι συχνές (≥ 1/1000, < 1/100).*

Κατηγορία Οργανικού Συστήματος	Πολύ Συχνές	Συχνές	Όχι συχνές	Επιπλέον μετά την κυκλοφορία του προϊόντος Μη γνωστής συχνότητας
Οφθαλμικές διαταραχές			Επηρεασμένη όραση	Διαταραχές όρασης
Διαταραχές του γαστρεντερικού		Κοιλιακό άλγος	Έμετος Δυσκοιλιότητα Ναυτία	
Γενικές διαταραχές και καταστάσεις της οδού χορήγησης		Αντίδραση στο σημείο της έγνοσης (περιλαμβάνονται πόνος, οίδημα, ερύθημα και φλεγμονή)	Κακουχία	
Διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος		Αντίδραση υπερευαισθησίας		Αναφυλακτικό σοκ
Παρακλινικές εξετάσεις		Βάρος αυξημένο		Αρτηριακή πίεση αυξημένη Προλακτίνη αίματος αυξημένη
Διαταραχές του μεταβολισμού και της θρέψης			Παχυσαρκία	
Διαταραχές του μυοσκελετικού συστήματος και του συνδετικού ιστού			Πόνος στον αυχένα	Μυαλγία
Διαταραχές του νευρικού συστήματος		Κεφαλαλγία		
Ψυχιατρικές διαταραχές			Μεταβολή διάθεσης	Ευμετταλητότητα συναισθήματος Κατάθλιψη Νευρικότητα
Διαταραχές του αναπαραγωγικού συστήματος και του μαστού	Αιμορραγία από τον κόλπο (περιλαμβάνονται Κολπική αιμορραγία, Αιμορραγία από απόσυρση, Αιμορραγία μήτρας, Κολπική έκκριση, Κολπική αιμορραγία περιλαμβανομένης της σταγονοειδούς αιμορραγίας)		Πόνος μαστών	
Διαταραχές του αναπνευστικού συστήματος, του θώρακα και του μεσοθωράκιου			Επίσταξη	
Διαταραχές του δέρματος και του υποδορίου ιστού		Ακμή	Κνησμός, Εξάνθημα, Κνίδωση	Αγγειοευρυπνικό οίδημα
Αγγειακές διαταραχές		Εξάψεις		Υπέρταση

Ξενική: Έχουν αναφερθεί αυξημένες τιμές λεμφοκυττάρων σε ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε θεραπεία με ανάλογα GnRH. Αυτή η δευτερογενής λεμφοκύτταση σχετίζεται προφανώς με τον ευνουχισμό που επάγεται από την GnRH και φαίνεται να υποδηλώνει ότι οι γοναδικές ορμόνες εμπλέκονται σε υποστροφή του θύμου αδένα. Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών: Η αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας του φαρμακευτικού προϊόντος είναι σημαντική. Επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση της σχέσης οφέλους-κινδύνου του φαρμακευτικού προϊόντος. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες μέσω του εθνικού συστήματος αναφοράς: **Ελλάδα:** Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, Μεσογείων 284, GR-15562 Χολαργός, Αθήνα, Τηλ: + 30 21 32040380/337, Φαξ: + 30 21 06549585, Ιστότοπος: http://www.eof.gr. **4.9 Υπερδοσολογία:** Οι φαρμακευτικές ιδιότητες του Arvekap 22,5 mg και του τρόπου χορήγησής του καθιστούν απίθανη την ακούσια ή εκούσια υπερδοσολογία. Δεν υπάρχει εμπειρία υπερδοσολογίας από κλινικές μελέτες. Δοκιμές σε ζώα υποδηλώνουν ότι με υψηλότερες δόσεις του Arvekap 22,5 mg, δεν είναι εμφανής καμία επίδραση στη συγκέντρωση των φυλετικών ορμονών και στην αναπαραγωγική οδό, πέραν των αναμενόμενων θεραπευτικών. Σε περίπτωση υπερδοσολογίας ενδείκνυται συμπτωματική αντιμετώπιση. **5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ: 5.1 Φαρμακοδυναμικές ιδιότητες:** Φαρμακοθεραπευτική κατηγορία: Ορμόνες και σχετικοί παράγοντες, ανάλογα της εκλυτικής ορμόνης κωδικός ATC: L02AE04. *Μηχανισμός δράσης και φαρμακοδυναμικές επιδράσεις:* Η τριπτορελίνη, ένας αγωνιστής GnRH, όταν χορηγείται συνεχώς και σε θεραπευτικές δόσεις, δρα ως ισχυρός ανασταλέας έκκρισης των γοναδοτροπινών. Μελέτες σε ζώα και ανθρώπους δείχνουν ότι μετά τη χορήγηση τριπτορελίνης επέρχεται μία αρχική και παροδική αύξηση των κυκλοφορούντων επιπέδων της ωχρινοτρόπου ορμόνης (LH), της ωοθυλακιοτρόπου ορμόνης (FSH), της τεστοστερόνης σε άρρενες και της οιστραδιόλης σε θήλεις. Ωστόσο, χρόνια και συνεχής χορήγηση τριπτορελίνης έχει ως αποτέλεσμα τη μειωμένη έκκριση LH και FSH και την κατασταλή της στεροειδογένεσης στους όρχεις και τις ωοθήκες. Σε άνδρες με καρκίνο του προστάτη: Μείωση των επιπέδων τεστοστερόνης στον ορό, σε επίπεδα που συνήθως απαντώνται σε χειρουργικά ευνουχισμένους άνδρες, συμβαίνει σε περίπου δύο έως τέσσερις εβδομάδες μετά την έναρξη της θεραπείας. Το Arvekap 22,5 mg έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να αποδεσμεύει 22,5 mg τριπτορελίνης κατά τη διάρκεια μίας περιόδου έξι μηνών. Μόλις επιτευχθούν για την τεστοστερόνη στον ορό επίπεδα ευνουχισμού έως το τέλος του πρώτου μήνα, αυτά διατηρούνται για όσο διάστημα οι ασθενείς λαμβάνουν την ένσητ τους κάθε εικοσαετέσκρις εβδομάδες. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την ατροφία των βοηθητικών γεννητικών οργάνων. Αυτές οι επιδράσεις είναι γενικά αντιστρεπτές με τη διακοπή της χρήσης του φαρμάκου. Η αποτελεσματικότητα της θεραπείας μπορεί να παρακολουθηθεί με τη μέτρηση των επιπέδων της τεστοστερόνης στον ορό και του ειδικού προστατικού αντιγόνου. Όπως έδειξε το πρόγραμμα κλινικών μελετών, με το Arvekap 22,5 mg υπήρξε μία μέση σχετική μείωση κατά 97% στο PSA κατά το Μήνα 6. Σε πειραματικά μοντέλα με ζώα, η χορήγηση τριπτορελίνης είχε ως αποτέλεσμα την ανασταλή της ανάπτυξης ορισμένων ορμονοευαίσθητων όγκων του προστάτη. Κλινική αποτελεσματικότητα και ασφάλεια σε καρκίνο του προστάτη: Χορήγηση Arvekap 22,5 mg με ενδομυϊκή ένεση σε ασθενείς με προχωρημένο καρκίνο του προστάτη για ένα αύνολο δύο δόσεων (δώδεκα μήνες), είχε ως αποτέλεσμα την επίτευξη επιπέδων ευνουχισμού για την τεστοστερόνη στο 97,59% των ασθενών μετά από τέσσερις εβδομάδες και τη διατήρηση των επιπέδων ευνουχισμού στο 93,0% των ασθενών από το Μήνα 2 έως το Μήνα 12 της θεραπείας. Σε ασθενείς με τοπικά προχωρημένο καρκίνο του προστάτη, ορμόνες τυχαιοποιημένες μακροχρόνιες κλινικές δοκιμές παρέχουν στοιχεία για το όφελος της θεραπείας στέρησης των ανδρογόνων (ADT) σε συνδυασμό με την ακτινοθεραπεία (RT) σε σύγκριση με την RT μόνο (RTOG 85-31, RTOG 86-10, EORTC 22863 , D'Amico et al, JAMA, 2008). Σε μια τυχαιοποιημένη μελέτης φάσης III (EORTC 22961) στην οποία συμμετείχαν 970 ασθενείς με τοπικά προχωρημένο καρκίνο του προστάτη (κυρίως T2c-T4 με ορισμένους T1c έως T2b ασθενείς με τοπική νόσο λεμφαδένων στην ιστολογική), εκ των οποίων 483 είχαν τεθεί σε βραχυχρόνιο ανδρογονικό αποκλεισμό (6 μήνες) και 487 σε μακροχρόνια θεραπεία (3 έτη) σε συνδυασμό με ακτινοθεραπεία, μια ανάλυση μη-κατωτερότητας συνέκρινε την βραχυχρόνια και τη μακροχρόνια συγχορηγούμενη και επακόλουθη στην ακτινοθεραπεία ορμονική θεραπεία με GnRH αγωνιστές, κυρίως τριπτορελίνη (62,2%) ή goserelin (30,1%). Η συνολική θνησιμότητα στα 5 έτη για την ομάδα «βραχυπρόθεσμης ορμονοθεραπείας» και την ομάδα «μακροπρόθεσμης ορμονοθεραπείας» ήταν 19,0% και 15,2% αντίστοιχα, με σχετικό κίνδυνο 1,42 (Δ.Ε. 95, 71% = 1,79; 95,71% Δ.Ε. = [1,09; 1,85], p = 0,65 για ισοτελεσματικότητα και p = 0,0082 για εκ των υστέρων έλεγχο της διαφοράς μεταξύ των ομάδων θεραπείας). Η ειδικά σχετιζόμενη με τον προστάτη θνητότητα εντός 5 ετών στην ομάδα «βραχυπρόθεσμης ορμονοθεραπείας» και στην ομάδα «μακροπρόθεσμης ορμονοθεραπείας» ήταν 4,78% και 3,2% αντίστοιχα, με σχετικό κίνδυνο 1,71 (95% [1,14 έως 2,57], p = 0,002). Η συνολική ποιότητα ζωής με τη χρήση QLQ-C30 δεν διέφερε σημαντικά μεταξύ των δύο ομάδων (P = 0,37). Αποδεικτικά δεδομένα για την ένδειξη του υψηλού κινδύνου εντοπισμένου καρκίνου του προστάτη βασίζονται σε δημοσιευμένες μελέτες με ακτινοθεραπεία σε συνδυασμό με GnRH ανάλογα. Αναλυθήκαν κλινικά δεδομένα από πέντε δημοσιευμένες μελέτες (EORTC 22863, RTOG 85-31, 92-02 RTOG, RTOG 8610, και D'Amico et al., JAMA, 2008), τα οποία όλα κατάδειχνύουν όφελος για το συνδυασμό των αναλόγων GnRH με την ακτινοθεραπεία. Σαφής διαφοροποίηση των αντίστοιχων πληθυσμών των μελετών για τις ενδείξεις του τοπικά προχωρημένου καρκίνου του προστάτη και του υψηλού κινδύνου εντοπισμένου καρκίνου του προστάτη δεν ήταν δυνατή στις δημοσιευμένες μελέτες. Σε ασθενείς με ανθεκτικό στον ευνουχισμό μεταστατικό καρκίνο του προστάτη, οι κλινικές μελέτες έχουν δείξει το όφελος από την προσθήκη abiraterone acetate, έναν ανασταλέα βιοσύνθεσης ανδρογόνων, ή enzalutamide, έναν ανασταλέα του αδρογονικού υποδοχέα, στα GnRH ανάλογα όπως η τριπτορελίνη. **Κλινική αποτελεσματικότητα και ασφάλεια σε παιδιά με πρώιμη ήβη:** Σε μία μη συγκριτική κλινική μελέτη, σε 44 παιδιά με κεντρική πρωιμη ήβη (39 κορίτσια και 5 αγόρια) χορηγήθηκαν συνολικά δύο ενδομυϊκές εγχύσεις του Arvekap 22.5 mg για 12 μήνες (48 εβδομάδες). Η καταστολή των διεγειρόμενων συγκεντρώσεων LH σε προ εφηβείας επίπεδα επιτεύχθηκε στο 95,5% των ασθενών τον μήνα 3 και σε 93,2% και 97,7% των ασθενών στους μήνες 6 και 12 αντίστοιχα. Η συνέπεια ήταν η υποχώρηση ή σταθεροποίηση των δευτερογενών χαρακτηριστικών του φύλου και η επιβράδυνση της επιταχυνόμενης ωρίμανσης και ανάπτυξης των οστών. Στα κορίτσια, η αρχική διέγερση των ωοθηκών κατά την έναρξη της θεραπείας, ακολουθούμενη από την επαγόμενη από τη θεραπεία απόσυρση των οιστρογόνων, μπορεί να οδηγήσει στον πρώτο μήνα, σε κολπική αιμορραγία ήπιας ή μέτριας έντασης. **5.2 Φαρμακοκινητικές ιδιότητες:** *Απορρόφηση:* Μετά από μία εφάπαξ ενδομυϊκή ένεση του Arvekap 22,5 mg σε ασθενείς με καρκίνο του προστάτη, ο t_{max} ήταν 3 (2-12 ώρες) και η C_{max} (0-169 ημέρες) ήταν 40,0 (22,2 – 76,8) ng/mL. *Σε παιδιά με πρώιμη ήβη η τmax ήταν 4 (2-8) ώρες και η Cmax (0-169 ημέρες) ήταν 39,9 (19,1 - 107,0) ng / ml.* Η τριπτορελίνη δεν συσσωρεύτηκε κατά τους δώδεκα μήνες της θεραπείας. *Κατανομή:* Αποτελέσματα φαρμακοκινητικών μελετών που διεξήχθηκαν σε υγιείς άνδρες υποδεικνύ-ουν ότι μετά από ενδοφλέβια χορήγηση μαζας τριπτορελίνης, αυτή κατανέμεται και κατοβολιζεται σύμφωνα με ένα μοντέλο τριών διαμερισμάτων, ενώ οι αντίστοιχοι χρόνοι ημίζωής είναι περίπου 6 λεπτά, 45 λεπτά και 3 ώρες. Ο όγκος κατανομής της τριπτορελίνης σε σταθερή κατάσταση μετά από ενδοφλέβια χορήγηση 0,5 mg triptorelin acetate σε υγιείς άρρενες εθελοντές είναι περίπου 30 L. Εφόσον δεν υπάρχουν στοιχεία ότι η τριπτορελίνη δεσμεύεται στις πρωτεΐνες του πλάσματος σε κλινικά σημαντικές συγκεντρώσεις, είναι απίθανες οι αλληλεπιδράσεις φαρμακευτικών προϊόντων οι οποίες οφείλονται σε εκτόπιση από θέσεις πρόσδεσης. *Βιομετασχηματισμός:* Μεταβολίτες της τριπτορελίνης δεν έχουν προσδιοριστεί σε ανθρώπους. Ωστόσο, ανθρώπινα φαρμακοκινητικά δεδομένα υποδηλώνουν ότι θραύσματα από το C-άκρο παραγόμενα μετά από αποικοδόμηση σε ιστούς, είτε διασπώνται τελείως μέσα στους ιστούς, είτε αποικοδομούνται περαιτέρω στο πλάσμα ή εκκαθαρίζονται από τα νεφρά. *Αποβολή:* Η τριπτορελίνη καταβολίζεται στο ήπαρ και στα νεφρά. Μετά από ενδοφλέβια χορήγηση 0,5 mg τριπτορελίνης σε υγιείς άρρενες εθελοντές, το 42% της δόσης απεκκρίθηκε στα ούρα ως ανέπαφη τριπτορελίνη, ενώ αυξήθηκε στο 62% σε ασθενείς με έκπτωση της ηπατικής λειτουργίας. Εφόσον η κάθαρση κρεατινίνης (Cl_{creat}) σε υγιείς εθελοντές ήταν 150 mL/min και μόνο 90 mL/min σε ασθενείς με έκπτωση της ηπατικής λειτουργίας, αυτό υποδεικνύει ότι το ήπαρ είναι σημαντικό σημείο καταβολισμού της τριπτορελίνης. Σε αυτούς τους υγιείς εθελοντές ο πραγματικός τελικός χρόνος ημίζωής της τριπτορελίνης ήταν 2,8 ώρες και η ολική κάθαρση της τριπτορελίνης ήταν 212 mL/min, με αυτή να εξαρτάται από ένα συνδυασμό ηπατικής και νεφρικής κάθαρσης. *Άλλοι Ειδικοί πληθυσμοί:* Μετά από ενδοφλέβια χορήγηση 0,5 mg τριπτορελίνης σε ασθενείς με μέτρια νεφρική ανεπάρκεια (Cl_{creat} 40 mL/min) η τριπτορελίνη εμφάνισε χρόνο ημίζωής αποβολής 6,7 ώρες, σε ασθενείς με σοβαρή νεφρική ανεπάρκεια (Cl_{creat} 8,9 mL/min) 7,81 ώρες και σε ασθενείς με έκπτωση της ηπατικής λειτουργίας (Cl_{creat} 89,9 mL/min) 7,65 ώρες. Δεν έχουν μελετηθεί συστηματικά οι επιδράσεις της ηλικίας και της φυλής στην φαρμακοκινητική της τριπτορελίνης. Ωστόσο, φαρμακοκινητικά στοιχεία που προέκυψαν από νέους υγιείς άρρενες εθελοντές ηλικίας 20 έως 22 ετών, με αυξημένη κάθαρση κρεατινίνης (περίπου 150 mL/min), έδειξαν ότι η τριπτορελίνη απομακρύνθηκε δύο φορές ταχύτερα στο νεανικό πληθυσμό. Αυτό συνδέεται με το γεγονός ότι η κάθαρση της τριπτορελίνης συσχετίζεται με την ολική κάθαρση κρεατινίνης, η οποία είναι γνωστό ότι ελαττώνεται με την ηλικία. Λόγω του μεγάλου περιθωρίου ασφάλειας της τριπτορελίνης και καθως το Arvekap 22,5 mg είναι μορφή παρατεταμένης αποδέσμευσης, δεν συνιστάται προσαρμογή της δόσης σε ασθενείς με έκπτωση της νεφρικής ή ηπατικής λειτουργίας. *Φαρμακοκινητικές / φαρμακοδυναμικές σχέσεις:* Δεν μπορεί να αξιολογηθεί άμεσα η σχέση φαρμακοκινητικής / φαρμακοδυναμικής της τριπτορελίνης καθώς είναι μη γραμμική και χρονοεξαρτώμενη. Μετά από οξεία χορήγηση σε εθελοντές χωρίς προηγούμενη θεραπεία, η τριπτορελίνη επάγει μία δοσοεξαρτώμενη αύξηση της απόκρισης των LH και FSH. Όταν χορηγείται σε μορφή παρατεταμένης αποδέσμευσης, η τριπτορελίνη, κατά τις πρώτες μέρες μετά τη χορήγηση, διεγείρει την έκκριση LH και FSH και κατά συνέπεια την έκκριση τεστοστερόνης. Όπως έχουν δείξει τα αποτελέσματα διαφορετικών μελετών βιοϊσοδυναμίας, η μέγιστη αύξηση της τεστοστερόνης επιτυγχάνεται μετά από περίπου τέσσερις ημέρες με μία ισοδύναμη C_{max} η οποία είναι ανεξάρτητη από το ρυθμό απελευθέρωσης της τριπτορελίνης. Η αρχική απάντηση δεν διατηρείται παρά τη συνεχή έκθεση στην τριπτορελίνη και ακολουθείται από μία προοδευτική και ισοδύναμη μείωση των επιπέδων τεστοστερόνης. Σε αυτή την περίπτωση, η έκταση της έκθεσης στην τριπτορελίνη μπορεί να ποικίλει αρκετά χωρίς να επηρεάζει τη συνολική επίδραση στα επίπεδα της τεστοστερόνης στον ορό. **5.3 Προκλινικά δεδομένα για την ασφάλεια:** Η τοξικότητα της τριπτορελίνης σε εξωενννητικά όργανα είναι χαμηλή. Τα αποτελέσματα που παρατηρήθηκαν σχετίζονταν κυρίως με την οξυνση των φαρμακολογικών επιδράσεων της τριπτορελίνης. Σε μελέτες χρόνιας τοξικότητας με κλινικά σχετικές δόσεις, η τριπτορελίνη επέφερε μακρο- και μικροσκοπικές αλλαγές στα αναπαραγωγικά όργανα αρσενικών αρουραίων, σκύλων και πιθήκων. Αυτές θεωρήθηκαν ως μία αντίδραση στην κατεσταλμένη λειτουργία των γονάδων η οποία προκλήθηκε από την φαρμακολογική δράση της ουσίας. Οι αλλαγές ήταν μερικώς αντιστρεπτές κατά τη διάρκεια της ανάρρωσης. Μετά από υποδόρια χορήγηση 10 μg/kg σε αρουραίους κατά τις ημέρες 6 έως 15 της κυισοφορίας, η τριπτορελίνη δεν προκάλεσε καμία εμβρυοτοξική, τερατογόνο ή άλλη επίδραση στην ανάπτυξη της επόμενης γενιάς (γενιά F1) ή στην αναπαραγωγική της ικανότητα. Στα 100 μg/kg παρατηρήθηκε μείωση της αύξησης του σωματικού βάρους της μητέρας και αυξημένος αριθμός υποστροφών του κυήματος. Η τριπτορελίνη δεν είναι μεταλλαξογόνος *in vitro* ή *in vivo*. Με την τριπτορελίνη δεν έχει αποδειχθεί καμία ογκογόνος επίδραση σε ποντίκια σε δόσεις έως 6000 μg/kg μετά από 18 μήνες θεραπείας. Μία μελέτη καρκινογένεσης σε αρουραίους, η οποία διήρκεσε 23 μήνες, έδειξε σχεδόν 100% επίπτωση καλοήθων όγκων της υπόφυσης σε κάθε επίπεδο δόσης που οδήγησαν σε πρόωρο θάνατο. Η αυξημένη επίπτωση υποφυσιακών όγκων στους αρουραίους είναι συχνή επίδραση η οποία σχετίζεται με τη χορήγηση αγωνιστών GnRH. Η κλινική σημασία αυτής της επίδρασης δεν είναι γνωστή. **6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: 6.1 Κατάλογος εκδόχων:** *Κάνις:* poly (d,l-lactide–co-glycolide), mannitol, carmellose sodium, polysorbate 80. *Διαλύτης:* Water for injections. **6.2 Ασυμβατότητες:** Ελλείψει μελετών σχετικά με τη συμβατότητα, το παρόν φαρμακευτικό προϊόν δεν πρέπει να αναμιγνύεται με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα. **6.3 Διάρκεια ζωής:** 3 έτη. Να χρησιμοποιείται αμέσως μετά την ανασύσταση. Από μικροβιολογικής άποψης, το έτοιμο προς χρήση ενέσιμο εναιώρημα πρέπει να χρησιμοποιείται αμέσως. Αν δεν χρησιμοποιηθεί αμέσως, οι κατά τη χρήση χρόνοι και συνθήκες αποθήκευσης πριν τη χρήση είναι ευθύνη του χρήστη και κανονικά θα πρέπει να μην υπερβαίνουν τις 24 ώρες στους 2 έως 8 °C. **6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά την φύλαξη του προϊόντος.** Μη φυλάσσετε σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 25 °C. Για τις συνθήκες φύλαξης του ανασυσταθέντος φαρμακευτικού προϊόντος βλέπε παράγραφο 6.3. **6.5 Φύση και συστατικά του περιέκτη:** Φιαλίδιο σκόνης: 6 ml, διάφανο ανοιχτό καφέ φιαλίδιο (γυαλί τύπου I) με πώμα βρωμοβουτυλίου και κάπακι αλουμινίου με σκούρο πράσινο αποσπώμενο κάλυμμα. Φύσιγγα διαλύτη: Διάφανη, άχρωμη φύσιγγα (γυαλί τύπου I) που περιέχει 2 ml στείρου διαλύτη για εναιώρημα. *Κουτί με:* 1 φιαλίδιο, 1 φύσιγγα και 1 συσκευασία που περιέχει 1 αύρηγα και 2 βελόνες για την ένεση. **6.6 Ιδιαίτερες προφυλάξεις απόρριψης και άλλος χειρισμός:** Το ενέσιμο εναιώρημα πρέπει να ανασυσταθεί με χρήση άσηπτης τεχνικής και μόνο χρησιμοποιώντας τη φύσιγγα διαλύτη για την ένεση. Οι οδηγίες ανασύστασης που αναφέρονται κατωτέρω όπως και στο φύλλο οδηγιών πρέπει να ακολουθούνται αυστηρά. Ο διαλύτης θα πρέπει να αναρροφηθεί με τη σύριγγα η οποία παρέχεται με χρήση της βελόνας για την ανασύσταση (20G, χωρίς αύστημα ασφαλείας) και να μεταφερθεί στο φιαλίδιο που περιέχει τη σκόνη. Το εναιώρημα πρέπει να ανασυσταθεί με ήπια οριζόντια ανακίνηση του φιαλιδίου ώστε να προκύψει ένα ομογενές, γαλακτώδες εναιώρημα. Μην αναστρέφετε το φιαλίδιο. Είναι σημαντικό να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει μη αναρροφημένη σκόνη στο φιαλίδιο.Το προκύπτον εναιώρημα πρέπει στη συνέχεια να αναρροφηθεί μέσα στη σύριγγα χωρίς να αναστραφεί το φιαλίδιο. Κατόπιν, η βελόνα για την ανασύσταση πρέπει να αλλαχθεί και να χρησιμοποιηθεί η βελόνα για την ένεση (20G, με συσκευή ασφαλείας) για να χορηγηθεί το προϊόν. Καθώς το προϊόν είναι εναιώρημα, η ένεση πρέπει να χορηγείται αμέσως μετά την ανασύσταση για να αποφευχθεί καθίζηση . Για εφάπαξ χρήση. Χρησιμοποιημένες βελόνες, χρησιμοποιητίκι υλικά, εναιώρημα ή άλλα άχρηστα πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις τοπικές απαιτήσεις. *Κάθε αχρησιμοποίητο φαρμακευτικό προϊόν ή υπόλειμμα πρέπει να απορρίπτεται σύμφωνα με τις κατά τόπους ισχύουσες σχετικές διατάξεις.* **7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:** IPSEN ΜΕΠΕ, Αγ. Δημητρίου 63, Άλιμος 174 56, Αθήνα. **8. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:** 29553/5-3-2020. **9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ/ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ:** Ημερομηνία πρώτης έγκρισης : 3-3-2011. Ημερομηνία τελευταίας ανανέωσης: 5-3-2020. **10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:** 08/07/2022

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

10 ΑΡΧ 11,25/3,75/22,5-Β/ΙΟΥΛ 2022.

• Τ.Π.: 425,32€
• Λ.Τ: 498,77€
• Δ.Τ.Φ.: 23/12/2021

IPSEN MON.ΕΠΕ
Αγ. Δημητρίου 63, 174 56 ΑΛΙΜΟΣ
Τηλέφωνο: 210 98 43 324, 210 98 58 930 & 210 98 58 940, Φαξ: 210 98 87 911
E-mail: ipsenepe@ipsen.com, http://www.ipsen.gr
Τηλέφωνα φαρμακοεπαγρύπνησης: 210 98 43 324, 210 98 58 930

IPSEN
Innovation for patient care

χορηγοί

Η Οργανωτική Επιτροπή θα ήθελε να εκφράσει τις ευχαριστίες στις Εταιρείες Χορηγούς κατά αλφαβητική σειρά:

AMGEN

ariti
Στήλη στον άνθρωπο

astellas

BAYER Bayer

BIANEΞ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΒΙΟΚΟΣΜΟΣ
RADIOPHARMACEUTICALS

DEMO ABEE
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ELPEN

GP PHARMA

ιατρική τομή
Ostomy & continence care experts

IPSEN
Innovation for patient care

janssen Oncology
PHARMACEUTICAL COMPANIES OF Johnson&Johnson

Lavipharm

MAVROGENIS

PharmaZac

RAFARM

RECORDATI

stilvi
για την υγεία

UNI-PHARMA
Pharmaceutical Laboratories S.A.
www.uni-pharma.gr

WinMedica
Serving Health for Life

ΒΙΟΚΟΣΜΟΣ
RADIOPHARMACEUTICALS

- **Διάγνωση με PSMA-PET**

- **Θεραπεία με RLT-PSMA**

ΒΙΟΚΟΣΜΟΣ Α.Ε.Β.Ε.
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΡΑΔΙΟΦΑΡΜΑΚΩΝ
Έδρα: Θέση Πάνορμος, 19500 Λαύριο
Υποκ/μα Α': ΒΙΠΑ Λακκώματος, 63080 Ν. Καλλικράτεια
Υποκ/μα Β': Λεωφ. Βουλιαγμένης 150, 16647 Γλυφάδα
ΤΗΛ: 22920 63900 | **FAX:** 22920 69235
www.biokosmos.gr

Ετήσιο Ουρολογικό Συνέδριο

σημειώσεις

σημειώσεις

Ετήσιο Ουρολογικό Συνέδριο

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Xtandi™ enzalutamide

1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Xtandi - 40 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία
Xtandi - 80 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία

2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
Xtandi - 40 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία: Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 40 mg enzalutamide.
Xtandi - 80 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία: Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 80 mg enzalutamide
Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ. παράγραφο 6.1.

3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο.
Xtandi – 40 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία: Κίτρινα στρογγυλά – επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία, χαραγμένα με το E 40.
Xtandi – 80 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία: Κίτρινα οβάλ – επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία, χαραγμένα με το E 80.

4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις
Το Xtandi ενδείκνυται για:
- τη θεραπεία του μεταστατικού, ορμονοευαίσθητου καρκίνου του προστάτη (mHSPC) σε συνδυασμό με θεραπεία στέρησης ανδρογόνων (ADT) σε ενήλικες άνδρες (βλ. παράγραφο 5.1).
- τη θεραπεία του μη μεταστατικού υψηλού κινδύνου ανθεκτικού στον ευνουχισμό καρκίνου του προστάτη (CRPC) σε ενήλικες άνδρες (βλ. παράγραφο 5.1).
- τη θεραπεία του μεταστατικού CRPC σε ενήλικες άνδρες οι οποίοι είναι ασυμπτωματικοί ή ήπια συμπτωματικοί έπειτα από αποτυχία της θεραπείας στέρησης ανδρογόνων και στους οποίους η χημειοθεραπεία δεν ενδείκνυται ακόμα κλινικά (βλ. παράγραφο 5.1).
- τη θεραπεία του μεταστατικού CRPC σε ενήλικες άνδρες των οποίων η νόσος έχει εξελιχθεί κατά τη διάρκεια ή μετά από θεραπεία με ντοσεταξέλη.

4.3 Αντενδείξεις
Υπερευαισθησία στη (στις) δραστική(ές) ουσία(ες) ή σε κάποιο από τα έκδοχα που αναφέρονται στην παράγραφο 6.1.
Γυναίκες που είναι ή μπορεί να μείνουν έγκυες (βλ. παραγράφους 4.6 και 6.6).

4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση
Κίνδυνος επιληπτικών κρίσεων: Η χρήση της enzalutamide έχει συσχετιστεί με επιληπτικές κρίσεις (βλ. παράγραφο 4.8). Η απόφαση για τη συνέχιση της θεραπείας σε ασθενείς που εμφανίζουν επιληπτικές κρίσεις πρέπει να λαμβάνεται ανά περίπτωση.
Σύνδρομο οπίσθιας αναστρέψιμης εγκεφαλοπάθειας (Posterior Reversible Encephalopathy Syndrome-PRES): Έχουν αναφερθεί σπάνιες αναφορές του συνδρόμου οπίσθιας αναστρέψιμης εγκεφαλοπάθειας (PRES) σε ασθενείς που λαμβάνουν Xtandi (βλέπε παράγραφο 4.8). Το PRES είναι μία σπάνια, αναστρέψιμη, νευρολογική διαταραχή, η οποία μπορεί να εκδηλωθεί με ραγδαία εξελισσόμενα συμπτώματα, συμπεριλαμβανομένων σπασμών, κεφαλαλγίας, σύγχυσης, τύφλωσης και άλλων οπτικών και νευρολογικών διαταραχών, με ή χωρίς σχετιζόμενη υπέρταση. Η διάγνωση του PRES απαιτεί επιβεβαίωση με απεικονιστικές εξετάσεις του εγκεφάλου, κατά προτίμηση μαγνητική τομογραφία του εγκεφάλου (MRI). Συνιστάται διακοπή του Xtandi σε ασθενείς που αναπτύσσουν PRES.
Δευτερογενείς Κύριες Κακοήθειες: Έχουν αναφερθεί περιστατικά δευτερογενών κύριων κακοηθειών σε ασθενείς που έλαβαν enzalutamide σε κλινικές μελέτες. Σε κλινικές μελέτες φάσης 3 τα πιο συχνά αναφερόμενα συμβάντα σε ασθενείς που έλαβαν enzalutamide και μεγαλύτερα από το εικονικό φάρμακο, ήταν καρκίνος ουροδόχου κύστης (0,3%), αδενοκαρκίνωμα παχέος εντέρου (0,2%), καρκίνωμα από μεταβατικό επιθήλιο (0,2%) και μεταβατικό καρκίνωμα ουροδόχου κύστης (0,1%). Οι ασθενείς θα πρέπει να συμβουλεύονται άμεσα το γιατρό τους εάν παρατηρήσουν σημάδια γαστρεντερικής αιμορραγίας, μακροσκοπική αιματουρία ή άλλα συμπτώματα όπως δυσουρία ή επιτακτική ανάγκη ούρησης κατά τη διάρκεια της θεραπείας με enzalutamide.
Ταυτόχρονη χρήση με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα: Η enzalutamide είναι ένας ισχυρός επαγωγέας ενζύμων και μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια της αποτελεσματικότητας πολλών ευρείας χρήσεως φαρμακευτικών προϊόντων (βλ. παραδείγματα στην παράγραφο 4.5). Συνεπώς μια ανασκόπηση των συγχορηγούμενων φαρμακευτικών προϊόντων πρέπει να διεξάγεται κατά την έναρξη της θεραπείας με enzalutamide. Η ταυτόχρονη χρήση της enzalutamide με φαρμακευτικά προϊόντα που είναι ευαίσθητα υποστρώματα πολλών μεταβολικών ενζύμων ή μεταφορείς (βλ. παράγραφο 4.5) πρέπει γενικά να αποφεύγεται εάν η θεραπευτική τους δράση είναι μεγάλης σημασίας για τον ασθενή, και εάν οι προσαρμογές της δόσης δεν μπορούν εύκολα να πραγματοποιηθούν βάσει της παρακολούθησης της αποτελεσματικότητας ή των συγκεντρώσεων στο πλάσμα.
Η συγχορήγηση με βαρφαρίνη και αντιπηκτικά ομοιάζοντα με κουμαρίνη πρέπει να αποφεύγεται. Εάν το Xtandi συγχορηγείται με ένα αντιπηκτικό που μεταβολίζεται από το CYP2C9 (όπως η βαρφαρίνη ή ασενοκουμαρόλη), πρέπει να διεξαχθεί επιπρόσθετη παρακολούθηση της Διεθνούς Ομαλοποιημένης Σχέσης (International Normalised Ratio-INR) (βλ. παράγραφο 4.5).
Νεφρική δυσλειτουργία: Απαιτείται προσοχή σε ασθενείς με σοβαρή νεφρική δυσλειτουργία καθώς η enzalutamide δεν έχει μελετηθεί σε αυτό τον πληθυσμό ασθενών.
Σοβαρή ηπατική δυσλειτουργία: Μια αύξηση του χρόνου ημίσειας ζωής της enzalutamide έχει παρατηρηθεί σε ασθενείς με σοβαρή ηπατική δυσλειτουργία, πιθανά συσχετιζόμενη με την αυξημένη κατανομή στους ιστούς. Η κλινική σημασία αυτής της παρατήρησης παραμένει άγνωστη. Ωστόσο, αναμένεται ένα παρατεταμένο χρονικό διάστημα για να φτάσουν οι συγκεντρώσεις στη σταθεροποιημένη κατάσταση και ο χρόνος μέχρι να επιτευχθεί η μέγιστη φαρμακολογική δράση καθώς και οι χρόνοι για την έναρξη και μείωση της ενζυμικής επαγωγής (βλ. παράγραφο 4.5) μπορεί επίσης να αυξηθούν.
Πρόσφατη καρδιαγγειακή νόσος: Στις μελέτες φάσης 3 αποκλείστηκαν ασθενείς με πρόσφατο έμφραγμα του μυοκαρδίου (κατά τους τελευταίους 6 μήνες) ή ασταθή στηθάγχη (κατά τους τελευταίους 3 μήνες), καρδιακή ανεπάρκεια κατηγορίας III ή IV κατά New York Heart Association (NYHA) εκτός αν το κλάσμα εξώθησης αριστερής κοιλίας (Left Ventricular Ejection Fraction-LVEF) ≥ 45%, βραδυκαρδία ή μη ελεγχόμενη υπέρταση. Αυτό πρέπει να λαμβάνεται υπόψη αν το Xtandi συνταγογραφείται σε αυτούς τους ασθενείς.
Η θεραπεία ανδρογονικού αποκλεισμού μπορεί να παρατείνει το διάστημα QT: Σε ασθενείς με ιστορικό ή ύπαρξη παραγόντων κινδύνου για παράταση του διαστήματος QT και σε ασθενείς που λαμβάνουν ταυτόχρονα φαρμακευτικά προϊόντα που ενδέχεται να παρατείνουν το διάστημα QT (βλ. παράγραφο 4.5), οι θεράποντες γιατροί πρέπει να αξιολογούν το ισοζύγιο οφέλους κινδύνου συμπεριλαμβανομένης της πιθανότητας για εμφάνιση κοιλιακής ταχυκαρδίας δίκην ριπιδίου (Torsade de pointes) πριν την έναρξη του Xtandi.
Χρήση με χημειοθεραπεία: Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα της ταυτόχρονης χρήσης του Xtandi με κυτταροτοξική χημειοθεραπεία δεν έχει τεκμηριωθεί. Η συγχορήγηση της enzalutamide δεν έχει καμία κλινικά σημαντική επίδραση στη φαρμακοκινητική της ενδοφλέβιας ντοσεταξέλης (βλ. παράγραφο 4.5). Ωστόσο, δεν μπορεί να αποκλειστεί μια αύξηση εμφάνισης ουδετεροπενίας επαγόμενης από τη ντοσεταξέλη.
Αντιδράσεις υπερευαισθησίας: Αντιδράσεις υπερευαισθησίας εκδηλώνονται με συμπτώματα που περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται οίδημα προσώπου, γλώσσας, χείλους ή φάρυγγα, ή εξάνθημα έχουν παρατηρηθεί με enzalutamide (βλέπε παράγραφο 4.8). Έχουν αναφερθεί σοβαρές δερματικές ανεπιθύμητες αντιδράσεις (SCARs) με την enzalutamide. Κατά τη συνταγογράφηση, οι ασθενείς θα πρέπει να ενημερώνονται για τα σημεία και τα συμπτώματα και να παρακολουθούνται στενά για δερματικές αντιδράσεις.
Έκδοχα: Το φάρμακο αυτό περιέχει λιγότερο από 1 mmol νατρίου (λιγότερο από 23 mg) ανά επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο, είναι αυτό που ονομάζουμε «ελεύθερο νατρίου».

4.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες
Περίληψη του προφίλ ασφάλειας: Οι πλέον συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες είναι εξασθένιση/κόπωση, εξάψεις, υπέρταση, κατάγματα, και πτώση. Άλλες σημαντικές ανεπιθύμητες ενέργειες περιλαμβάνουν ισχαιμική καρδιακή νόσο και επιληπτικές κρίσεις. Επιληπτική κρίση παρουσιάστηκε στο 0,5% των ασθενών που έλαβαν enzalutamide, στο 0,2% των ασθενών που έλαβαν εικονικό φάρμακο και στο 0,3% των άσθενών που έλαβαν βικαλουταμίδη. Έχουν αναφερθεί σπάνιες περιπτώσεις του συνδρόμου οπίσθιας αναστρέψιμης εγκεφαλοπάθειας σε ασθενείς που έλαβαν enzalutamide (βλέπε παράγραφο 4.4).
Κατάλογος ανεπιθύμητων ενεργειών σε μορφή πίνακα: Οι ανεπιθύμητες ενέργειες που παρατηρήθηκαν κατά τη διάρκεια κλινικών μελετών παρατίθενται παρακάτω ανά κατηγορία συχνότητας εμφάνισης. Οι κατηγορίες συχνότητας εμφάνισης ορίζονται ως ακολούθως: πολύ συχνές (≥ 1/10), συχνές (≥ 1/100 έως < 1/10), όχι συχνές (≥1/1.000 έως < 1/100), σπάνιες (≥ 1/10.000 έως < 1/1.000), πολύ σπάνιες (< 1/10.000), μη γνωστές (δεν μπορούν να εκτιμηθούν με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα). Εντός κάθε κατηγορίας συχνότητας εμφάνισης, οι ανεπιθύμητες ενέργειες παρατίθενται κατά φθίνουσα σειρά σοβαρότητας.

Πίνακας 1: Ανεπιθύμητες ενέργειες που αναγνωρίστηκαν σε ελεγχόμενες κλινικές δοκιμές και μετά την κυκλοφορία του φαρμάκου

Κατηγορία/οργανικό σύστημα σύμφωνα με το MedDRA	Ανεπιθύμητες ενέργειες και συχνότητα
Διαταραχές του αιμοποιητικού και του λεμφικού συστήματος	Όχι συχνές: λευκοπενία, ουδετεροπενία Μη γνωστές*: θρομβοπενία
Διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος	Μη γνωστές*: οίδημα προσώπου, οίδημα γλώσσας, οίδημα χείλους, οίδημα φάρυγγα
Ψυχιατρικές διαταραχές	Συχνές: άγχος Όχι συχνές: οπτική ψευδαίσθηση
Διαταραχές του νευρικού συστήματος	Συχνές: κεφαλαλγία, επηρεασμένη μνήμη, αμνησία, διαταραχή στην προσοχή, δυσγευσία, σύνδρομο ανήσυχων ποδιών Όχι συχνές: νοητική διαταραχή, επιληπτικές κρίσεις[Φ] Μη γνωστές*: σύνδρομο οπίσθιας αναστρέψιμης εγκεφαλοπάθειας
Καρδιακές διαταραχές	Συχνές: ισχαιμική καρδιακή νόσος[†] Μη γνωστές*: παράταση του διαστήματος QT (βλ. παραγράφους 4.4 και 4.5)
Αγγειακές διαταραχές	Πολύ συχνές: εξάψεις, υπέρταση
Διαταραχές του γαστρεντερικού	Μη γνωστές*: ναυτία, έμετος, διάρροια
Διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού	Συχνές: ξηροδερμία, κνησμός Μη γνωστές*: εξάνθημα
Διαταραχές του μυοσκελετικού συστήματος και του συνδετικού ιστού	Πολύ συχνές: κατάγματα[‡] Μη γνωστές*: μυαλγία, μυϊκοί σπασμοί, μυϊκή αδυναμία, οσφυαλγία
Διαταραχές του αναπαραγωγικού συστήματος και του μαστού	Συχνές: γυναικομαστία
Γενικές διαταραχές και καταστάσεις της οδού χορήγησης	Πολύ συχνές: εξάντληση, κόπωση
Κακώσεις, δηλητηριάσεις και επιπλοκές θεραπευτικών χειρισμών	Πολύ συχνές: πτώση

* Αυθόρμητες αναφορές από την εμπειρία μετά την κυκλοφορία του φαρμάκου
Φ Όπως αξιολογήθηκε από τυποποιημένα ερωτήματα MedDRA (SMQs) των «Σπασμών» συμπεριλαμβανομένων των σπασμών, σπασμών γενικευμένης επιληψίας, σύνθετων εστιακών επιληπτικών κρίσεων, εστιακών επιληπτικών κρίσεων και status epilepticus. Αυτό περιλαμβάνει σπάνιες περιπτώσεις επιληπτικών κρίσεων με επιπλοκές που οδηγούν σε θάνατο.
† Όπως αξιολογήθηκε από τυποποιημένα ερωτήματα MedDRA (SMQs) «Εμφράγμα του μυοκαρδίου» και «Άλλη ισχαιμική καρδιακή νόσο», συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων προτιμώμενων όρων που παρατηρήθηκαν σε τουλάχιστον δύο ασθενείς σε τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες με εικονικό φάρμακο μελέτες φάσης 3: στηθάγχη, στεφανιαία νόσο, έμφραγμα του μυοκαρδίου, οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου, οξύ στεφανιαίο σύνδρομο, ασταθής στηθάγχη, ισχαιμία του μυοκαρδίου και αρτηριοσκλήρυνση στεφανιαίας αρτηρίας.
‡ Περιλαμβάνει όλους τους προτιμώμενους όρους με τη λέξη «κάταγμα» στα οστά.

Περιγραφή επιλεγμένων ανεπιθύμητων ενεργειών
Επιληπτική κρίση
Στις ελεγχόμενες κλινικές μελέτες, 24 (0,5%) από τους 4.403 ασθενείς που υποβλήθηκαν σε θεραπεία με ημερήσια δόση 160 mg enzalutamide εμφάνισαν επιληπτική κρίση, ενώ τέσσερις ασθενείς (0,2%) που έλαβαν εικονικό φάρμακο και ένας ασθενής (0,3%) που έλαβε βικαλουταμίδη εμφάνισαν επιληπτική κρίση. Η δόση φαίνεται να αποτελεί σημαντικό προγνωστικό παράγοντα του κινδύνου εμφάνισης επιληπτικής κρίσης, όπως αντικατοπρίζεται από τα προκλινικά δεδομένα και από τα δεδομένα από μια μελέτη κλιμάκωσης της δόσης. Στις ελεγχόμενες κλινικές μελέτες, εξαιρέθηκαν οι ασθενείς με προηγούμενη επιληπτική κρίση ή με παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση επιληπτικής κρίσης. Σε μια δοκιμή μονού σκέλους 9785-CL-0403 (UPWARD) για την αξιολόγηση της επίπτωσης των επιληπτικών κρίσεων σε ασθενείς με προδιαθεσικούς παράγοντες για εκδήλωση επιληπτικών κρίσεων (από τους οποίους 1,6% είχαν ιστορικό επιληπτικών κρίσεων), 8 από 366 (2,2%) ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με enzalutamide εμφάνισαν μια επιληπτική κρίση. Η διάμεση διάρκεια της θεραπείας ήταν 9,3 μήνες.
Δεν είναι γνωστός ο μηχανισμός μέσω του οποίου η enzalutamide μπορεί να μειώσει τον ουδό των επιληπτικών κρίσεων, αλλά θα μπορούσε να σχετιστεί με τα δεδομένα από in vitro μελέτες που δείχνουν ότι η enzalutamide και ο ενεργός μεταβολίτης της προσδένονται και μπορεί να αναστείλουν τη δραστικότητα των διαύλων των ιόντων χλωρίου του GABA.
Ισχαιμική καρδιακή νόσος
Σε τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτες ελεγχόμενες με εικονικό φάρμακο, η ισχαιμική καρδιακή νόσος εμφανίστηκε στο 3,9% των ασθενών που έλαβαν enzalutamide και ADT συγκριτικά με 1,5% των ασθενών που έλαβαν εικονικό φάρμακο και ADT. Δεκαπέντε (0,4%) ασθενείς που έλαβαν enzalutamide και 2 (0,1%) ασθενείς που έλαβαν εικονικό φάρμακο εμφάνισαν συμβάν ισχαιμικής καρδιακής νόσου που οδήγησε σε θάνατο.
Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών
Η αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας του φαρμακευτικού προϊόντος είναι σημαντική. Επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση της σχέσης οφέλους-κινδύνου του φαρμακευτικού προϊόντος. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες μέσω:
Ελλάδα: Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, Μεσογείων 284, GR-15562 Χολαργός, Αθήνα. Τηλ: + 30 21 32040380/337, Φαξ: + 30 21 06549585 , Ιστότοπος: http://www.eof.gr
Κύπρος: Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, Υπουργείο Υγείας, CY-1475 Λευκωσία. Τηλ: +357 22608607, Φαξ: + 357 22608669
Ιστότοπος: www.moh.gov.cy/phs

7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Astellas Pharma Europe B.V., Sylviusweg 62 , 2333 BE Leiden, Ολλανδία

8. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:
EU/1/13/846/002 (40 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία), EU/1/13/846/003 (80 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία)

9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
Ημερομηνία πρώτης έγκρισης: 21 Ιουνίου 2013
Ημερομηνία τελευταίας ανανέωσης: 8 Φεβρουαρίου 2018

10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:
24 Μαΐου 2022

Λεπτομερείς πληροφορίες για το παρόν φαρμακευτικό προϊόν είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων: http://www.ema.europa.eu.

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ

Ελλάδα*

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ	ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΤΙΜΗ
40mg/TAB	Κουτί Χ 112 επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία	€ 2.261,67

Κύπρος*

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ	ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ
40mg/TAB	Κουτί Χ 112 επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία	€ 3.009,25

*Κυκλοφορούν μόνο τα 40 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την **«ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»**

astellas

Astellas Pharmaceuticals A. E. B. E.
Αγησιλάου 6-8, 151 23 Μαρούσι, Αθήνα.
Τηλ. 210 8189 900, Fax: 216 8008 998
www.astellas.com/gr

Τοπικός Αντιπρόσωπος/
Διανομέας προϊόντων Astellas στην Κύπρο:
Novagem Ltd, Τηλ.: 00357 22483858

XTA/ADV 2/07.2022

ΤΟ ΝΕΟΤΕΡΟ ΑΝΤΙΑΝΔΡΟΓΟΝΟ ΜΕ ΤΟ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΦΑΣΜΑ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ [1-9]

ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΣΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ mHSPC

71%

ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΗΤΑΝ ΕΝ ΖΩΗ ΣΤΑ 4 ΕΤΗ [6]

ΣΥΝΔΥΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΟΥ ΔΙΝΕΙ Η ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΜΕ XTANDI™

XTA/ADV/2.07.2022

Όταν οι ασθενείς σας παρουσιάζουν προχωρημένο καρκίνο του προστάτη είναι καιρός για δράση.

Το **XTANDI™** είναι μια από του στόματος χορηγούμενη θεραπεία με αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα στην πρώτη γραμμή του mHSPC, του υψηλού κινδύνου nmCRPC και του ασυμπτωματικού / ήπια συμπτωματικού mCRPC.[1-6]

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ

Η σύντομη ΠΧΠ του προϊόντος δημοσιεύεται στη σελίδα ...27.. του παρόντος εντύπου.
Για περαιτέρω πληροφορίες συμβουλευτείτε την ΠΧΠ που διατίθεται από την Astellas Pharmaceuticals AEBE, κατόπιν αιτήσεως.
Ελλάδα: Νοσοκομειακή τιμή (Κουτί x 112 επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία - 40 mg /TAB): €2.261,67
Κύπρος: Λιανική τιμή με ΦΠΑ (Κουτί X 112 επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία - 40mg/TAB): € 3.009,25

Οι πλέον συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες είναι εξασθένιση/κόπωση, εξάψεις, υπέρταση, κατάγματα, και πτώση[1].
mHSPC: μεταστατικός ορμονοευαίσθητος καρκίνος του προστάτη, nmCRPC: μη μεταστατικός, ανθεκτικός στον ευνουχισμό, καρκίνος του προστάτη,
mCRPC:μεταστατικός, ανθεκτικός στον ευνουχισμό καρκίνος του προστάτη

1. Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος XTANDI™, **2.**Stemberg CN et al. N Engl J Med 2020; 382: 2197–206, **3.** Beer TM et al. Eur Ural 2017; 71: 151–54, **4.** Armstrong AJ et al. J Clin Oncol 2019; 37(32): 2974–86, **5.** Hussain M et al. N Engl J Med 2018; 378(26): 2465–74, **6.** Armstrong AJ e al. J.. Clin Oncol 2022; 40: 1616-22, **7.** Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος Αμπιρατερόνης, **8.** Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος Απαλουταμίδης, **9.** Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος Νταρολουταμίδης

astellas
Astellas Pharmaceuticals A. E. B. E.
Αγησιλάου 6-8, 151 23 Μαρούσι, Αθήνα.
Τηλ. 210 8189 900, Fax: 216 8008 998
www.astellas.com/gr

Τοπικός Αντιπρόσωπος/
Διανομέας προϊόντων Astellas στην Κύπρο:
Novagem Ltd, Τηλ: 00357 22483858

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την **«ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»**

Xtandi™
enzalutamide